



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 069.1/I-PDM/IRM/I/2026

Tentang
Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis Tahun 2026

Disusun oleh :
Kepala Unit Rekam Medis



(**Annisa Aulia Savira, A.Md.Kes**)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah. M. Kes. AFP**)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(**dr. Resti Lestantini, M. Kes**)

TIM PENYUSUN

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. dr. Amanda Firmandani
3. Dr. dr. Aslichah. M. Kes. AFP
4. Annisa Aulia Savira, A.Md.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengorganisasian Rekam Medis dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis ini, pelayananan unit rekam medis Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 30 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.	1
1.2 TUJUAN PEDOMAN	1
1.3 RUANG LINGKUP	2
1.4 BATASAN OPERASIONAL	2
BAB II	3
STANDAR KETENAGAAN	3
2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA	3
2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN	3
2.3 PENGATURAN JAGA	3
BAB III	4
STANDAR FASILITAS	4
3.1 DENAH RUANG INSTALASI REKAM MEDIS	4
3.2 STANDAR FASILITAS INSTALASI REKAM MEDIS	5
BAB IV	6
KEMAMPUAN PELAYANAN	6
BAB V	7
TATA LAKSANA PELAYANAN	7
5.1 PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN	7
1. PASIEN BARU	7
2. PASIEN LAMA	8
5.2 PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP	9
1. Pasien Umum	9
2. Pasien BPJS	10
5.3 PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT	10
5.4 MENAHAN PASIEN UNTUK OBSERVASI	11
5.5 TATA LAKSANA PENANGANAN PASIEN BILA TEMPAT TIDUR PENUH	11
5.6 SISTEM IDENTIFIKASI DAN PENOMORAN	12
1. Sistem Penamaan	12
2. Sistem Penomoran dan Penjajaran Rekam Medis	13
5.7 SIMBOL DAN TANDA KHUSUS	14
5.8 PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN DOKUMEN REKAM MEDIS	14
1. Pengendalian Rekam Medis	14
2. Pengembalian Dokumen Rekam Medis	14
3. Penyimpanan Rekam Medis	14
4. Fasilitas Fisik Ruang Penyimpanan	15
6. Sampul Pelindung Rekam Medis	15
5.9 PEREKAM KEGIATAN PELAYANAN MEDIS	16
1. Penanggung Jawab Pengisian Rekam Medis	16
2. Pencatatan (<i>Recording</i>)	17
3. Ketentuan Pengisian Dokumen Rekam Medis	24
5.10 PENGOLAHAN DATA MEDIS	24
1. Perakitan (<i>Assembling</i>) Rekam Medis	25
2. Kodefikasi Diagnosa dan Tindakan (<i>Coding</i>)	28

3. Analisa Dokumen Rekam Medis (<i>Review</i> Dokumen Rekam Medis)	30
4. Indeks	30
5.11 TATA CARA PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN REKAM MEDIS	31
1. Pengeluaran Rekam Medis	31
2. Petunjuk Keluar (<i>Outguide / Tracer</i>)	31
3. Ketentuan dan Prosedur Penyimpanan Lainnya	32
4. <i>Distribusi</i> Rekam Medis	32
5.12 JANGKA WAKTU PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN KERAHASIAAN	32
BAB VI	34
LOGISTIK	34
BAB VII	35
KESELAMATAN PASIEN	35
BAB VIII	36
KESELAMATAN KERJA	36
BAB IX	38
PENINGKATAN MUTU	38
9.1 INDIKATOR MUTU	38
9.2 URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	39
BAB X	45
PENUTUP	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Ruang Rekam Medis

4

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Distribusi Ketenagaan Rekam Medis	3
Table 2.2 Pengaturan Jam Kerja	3
Table 3.1 Standart Fasilitas Instalasi Rekam Medis	5
Table 5.1 Penanggung Jawab Pengisian DRM	17
Table 6.1 Logistik di Rekam Medis	34
Table 9.1 Macam-macam Indikator Mutu di RS Prima Husada Malang	38
Table 9.2 Indikator Kejadian Keterlambatan Laporan RL 1-5	39
Table 9.3 Indikator Kejadian Keterlambatan Laporan KLB	39
Table 9.4 Indikator Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	40
Table 9.5 Indikator Angka Ketidaklengkapan Pengkajian Awal Medis (DPJP) Pasien RI 1x24 jam	41
Table 9.6 Indikator Kejadian Ketidaklengkapan Laporan Operasi	41
Table 9.7 Indikator Kejadian Ketidaklengkapan Form Inform Consent	42
Table 9.8 Indikator Tingkat Hunian Rawat Inap	42
Table 9.9 Indikator Survey Pemahaman Staf Terhadap Evakuasi Pasien	43
Table 9.10 Indikator Kejadian Ketidaklengkapan Ringkasan Pulang	43



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR : 069.1/I-PDM/IRM/I/2026

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI REKAM MEDIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dari setiap gugus tugas/ unit pelayanan yang ada;
 - b. Bahwa agar pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Prima Husada dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit sebagai landasan bagi penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit Prima Husada Malang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada di Malang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada
 9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI REKAM MEDIS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
- (2) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
- (3) Dokter Penanggung Jawab Pelayanan adalah dokter yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan klinis sesuai surat penugasan klinisnya
- (4) Perawat Penanggung Jawab Asuhan adalah perawat yang bertanggung jawab terhadap asuhan pasien sejak pasien masuk sampai pulang dan mempunyai kompetensi dan kewenangan keperawatan
- (5) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
- (6) Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.
- (7) Dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang catatan observasi dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan rekaman elektro diagnostik.
- (8) Pengertian system elektronik , Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik
- (9) Penyelenggaran system elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara mandiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
- (10) Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

-
- (11) Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara mandiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 2

- (1) Rekam medis harus dibuat secara tertulis,serta membubuhkan nama dan tanda tangan staf klinis yang menulis di rekam medis
- (2) Rekam medis elektronik harus dibuat secara tertulis di system rekam medis elektronik dan lengkap, serta membubuhkan nama dan tanda tangan spesimen staf klinis yang ada di system rekam medis elektronik.
- (3) Setiap pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis.
- (4) Rekam medis harus dapat dibaca (legible), dapat dipercaya (reliable), tepat (precise), lengkap (complete), konsisten (consistent), jelas (clear), tepat waktu (timely)
- (5) Review rekam medis harus dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan mutu rekam medis sesuai dengan ayat (3)
- (6) Review melibatkan staff medis, keperawatan dan PPA lainnya yang memiliki otoritas pengisian rekam medis non elektronik maupun di rekam medis elektronik
- (7) Review rekam medis non elektronik dan elektronik secara kuantitatif dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan tiap bulan
- (8) Review rekam medis elektronik akan dilakukan oleh tim review rekam medis.

BAB II

PENGISIAN DAN HAK AKSES REKAM MEDIS

Pasal 3

- (1) Rumah sakit menetapkan individu yang berwenang mengisi rekam medis elektronik maupun non elektronik dan memahami cara melakukan koreksi.

-
- (2) PPA yang berwenang dalam pengisian rekam medis elektronik dan non elektronik wajib mencantumkan nama dan tanda tangan.
 - (3) PPA yang berwenang dalam pengisian rekam medis elektronik dan non elektronik wajib mencantumkan tanggal dan jam .
 - (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan (koreksi) rekam medis elektronik unit terkait akan melaporkan ke pihak rekam medis, kemudian pihak rekam medis akan berkolaborasi dengan IT untuk melakukan pengkoreksian rekam medis elektronik

Pasal 4

- (1) Individu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah tenaga kesehatan yang mempunyai akses ke rekam medis antara lain:
 - (a) Profesional pemberi asuhan yang telah mendapat kewenangan terhadap pasien terkait;
 - (b) Staf klinis pemberi asuhan terhadap pasien terkait;
 - (c) Staf rekam medis sesuai penugasannya;
 - (d) Direktur dan atau jajaran manajemen sesuai kebutuhan;
 - (e) Komite Medis/Subkomite terkait sesuai kebutuhan;
 - (f) Komite Keperawatan/Subkomite terkait sesuai kebutuhan
 - (g) Tim review rekam medis;
 - (h) Tim casemix;
 - (i) Staf keuangan;
 - (j) Tenaga kesehatan atau peserta didik yang telah mendapat ijin Direktur/Kepala Rumah Sakit.
- (2) Tenaga kesehatan yang mempunyai akses ke rekam medis dan berhak menulis/mengisi rekam medis adalah staf klinis terhadap pasien terkait.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan cara :
 1. pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.
 2. Perbaikan data dilakukan setelah mendapatkan persetujuan perekam medis dan informasi kesehatan atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
- (5) Rekam medis elektronik dan non elektronik disimpan dilokasi dan di dalam sistem yang aman dan media penyimpanan berbasis digital berupa :
 - a. Server
 - b. Sistem komputasi awan (cloud computing) yang tersertifikasin sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan
 - c. Media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan yang berbasis digital wajib memiliki cadangan data (back up system)
- (7) Cadangan data atau back up server sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diletakan pada tempat yang berbeda dari lokasi fasilitas pelayanan kesehatan
 - b. Dilakukan secara periodik
 - c. Dituangkan dalam standar prosedur operasional masing masing fasilitas pelayanan kesehatan
- (8) Rekam medis elektronik bisa diakses oleh tenaga kesehatan pada ayat (1) yang memiliki hak barcode

BAB III KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN Pasal 5

- (1) Berkas rekam medis milik rumah sakit.
- (2) Isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (3) Pasien mempunyai akses Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
- (4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.
- (5) Pemanfaatan rekam medis yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya.
- (6) Pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien, bila digunakan untuk kepentingan Negara.

BAB IV STANDAR KODE, SIMBOL DAN SINGKATAN

Pasal 6

- (1) Terdapat regulasi standardisasi kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, definisi, simbol dan singkatan yang digunakan dan yang tidak boleh digunakan, serta dimonitor pelaksanaannya.
- (2) Standardisasi berguna untuk mencegah terjadi salah komunikasi dan potensi kesalahan
- (3) Penggunaan secara seragam kode diagnosis dan prosedur memudahkan pengumpulan data dan analisis nya sesuai dengan peraturan per undang-undangan
- (4) Singkatan dapat menjadi masalah dan mungkin berbahaya,terutama berkaitan dengan penulisan resep obat.
- (5) Ketentuan tersebut dilaksanakan dan dievaluasi.
- (6) Rumah sakit menetapkan standar kode, simbol dan singkatan yang digunakan oleh PPA

BAB V KERAHASIAAN DAN PRIVASI Pasal 7

- (1) Terdapat regulasi mengenai privasi dan kerahasiaan informasi terkait data pasien dan hak akses terhadap isi rekam medis berdasar atas peraturan perundang-undangan.

-
- (2) Terdapat bukti regulasi dilaksanakan.
 - (3) Rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi :
 - a. Kerahasiaan
 - b. Integritas
 - c. Ketersediaan
 - (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) ,merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses , sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebaran.
 - (5) Integritas sebagaimana di maksud pada ayat 3 huruf (b),merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi akses untuk mengubah.
 - (6) Ketersediaan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 3 huruf (c),merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat di akses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang di tetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (7) Kepatuhan pelaksanaan regulasi dimonitor

Pasal 8

- (1) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:
 - a. untuk kepentingan kesehatan pasien;
 - b. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
 - c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
 - d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien;
- (3) Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

BAB VI

ISI SPESIFIK REKAM MEDIS

Pasal 9

- (1) Ada regulasi tentang isi spesifik dari berkas rekam medis pasien yang ditentukan oleh rumah sakit untuk kesinambungan asuhan oleh PPA.

-
- (2) Rekam medis berisi informasi yang memadai untuk mengidentifikasi pasien.
 - (3) Rekam medis berisi informasi yang memadai untuk mendukung diagnosis.
 - (4) Rekam medis berisi informasi yang memadai untuk memberi justifikasi asuhan dan pengobatan.
 - (5) Rekam medis berisi informasi yang memadai untuk mendokumentasikan pemberian dan hasil pengobatan.
 - (6) Aktivitas manajer pelayanan pasien (MPP) dicatat dalam rekam medis.

BAB VII PENGKAJIAN AWAL

Pasal 10

- (1) Rumah sakit menentukan isi, jumlah, dan jenis pengkajian awal pada disiplin medis dan keperawatan.
- (2) Isi minimal pengkajian awal antara lain :
 - a) Identitas pasien
 - b) Riwayat alergi
 - c) Tanggal dan jam kunjungan
 - d) Anamnesis
 - 1) Keluhan saat ini
 - 2) Riwayat kesehatan
 - 3) Aloanamnesis
 - 4) Kondisi umum
 - e) Status fisik
 - 1) Tanda vital
 - 2) Kondisi nutrisi
 - 3) Penandaan
 - 4) Pemeriksaan penunjang
 - 5) Diagnosis medis
 - 6) Masalah
 - 7) Rencana asuhan/terapi
 - 8) Tolak ukur/sasaran yang di capai
 - f) KIE
 - 1) Edukasi ke pasien (TTD pasien ,keluarga dan dokter)
- (3) Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis pengkajian awal disiplin medis.
- (4) Ada bukti pelaksanaan isi, jumlah dan jenis pengkajian awal disiplin keperawatan.
- (5) Ada bukti keterlibatan keluarga dalam melengkapi pengkajian awal

Pasal 11

- (1) pengkajian awal medis rawat jalan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. riwayat alergi;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. diagnosis;
 - e. rencana asuhan
 - f. kebutuhan edukasi (KIE)
- (2) pengkajian awal keperawatan rawat jalan sekurang-kurangnya meliputi:

-
- a. bio-psiko-spiritual,sosial,kultural
 - b. skrining dan pengkajian nyeri
 - c. status fungsional
 - d. risiko jatuh
 - e. risiko nutrisi
 - f. kebutuhan edukasi (KIE)
 - g. masalah keperawatan

-
- h. rencana asuhan
- (3) pengkajian awal medis rawat inap sekurang-kurangnya meliputi:
- a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. riwayat alergi;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. pemeriksaan penunjang
 - e. diagnosis;
 - f. masalah medis dan keperawatan;
 - g. rencana asuhan
 - h. kebutuhan edukasi (KIE)
- (4) pengkajian awal keperawatan rawat inap sekurang-kurangnya meliputi:
- a. bio-psiko-spiritual, sosial, kultural dan ekonomi
 - b. skrining dan pengkajian nyeri;
 - c. status fungsional;
 - d. risiko jatuh;
 - e. risiko nutrisi;
 - f. masalah keperawatan;
 - g. rencana asuhan
 - h. identifikasi pemulangan pasien yang kompleks
 - i. kebutuhan edukasi (KIE)
- (5) pengkajian awal medis gawat darurat sekurang-kurangnya meliputi :
- a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. riwayat alergi;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. diagnosis;
 - e. masalah
 - f. rencana asuhan
 - g. kondisi pasien sebelum meninggalkan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut;
 - h. kebutuhan edukasi (KIE)
- (6) pengkajian awal keperawatan gawat darurat sekurang-kurangnya meliputi:
- a. bio-psiko-spiritual;
 - b. skrining dan pengkajian nyeri
 - c. status fungsional
 - d. risiko jatuh
 - e. risiko nutrisi
 - f. masalah keperawatan
 - g. rencana asuhan
 - h. kebutuhan edukasi (KIE)
- (7) Pengkajian awal medis dan keperawatan dilaksanakan oleh profesional pemberi asuhan yang kompeten dan berwenang sesuai rincian kewenangan klinis yang ditetapkan.
- (8) Pengkajian awal rawat inap harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap
- (9) Pengkajian awal rawat jalan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 jam setelah dilakukan pengkajian

-
- (10) Pengkajian gawat darurat harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dilakukan asuhan sesuai kebutuhan pasien
 - (11) Pengkajian gawat darurat harus memuat waktu kedatangan dan keluar pasien

Pasal 12

- (1) Isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sebagai pengkajian tambahan.
- (2) Penerimaan nilai kritis hasil pemeriksaan diagnostik tercatat di dalam rekam medis.
- (3) Alasan penundaan dan kelambatan pelayanan dan informasi tentang alternative yang tersedia sesuai kebutuhan klinis pasien tercatat di dalam rekam medis.
- (4) Proses perencanaan pemulangan pasien (P3) dan pelaksanaannya dicatat di rekam medis
- (5) Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan masal dicatat dalam rekam medis dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku.

PENKAJIAN GIZI

Pasal 13

- (1) Rumah sakit menetapkan kriteria risiko nutrisi yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang.
- (2) Pasien diskriminasi untuk risiko nutrisi sebagai bagian dari pengkajian awal
- (3) Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, produk darah, pengambilan spesimen, dan pemberian diet.
- (4) Pasien dengan risiko nutrisi dilanjutkan dengan pengkajian gizi.

PENGKAJIAN RISIKO JATUH

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit menetapkan kriteria pengkajian kebutuhan fungsional dan risiko jatuh, yang dikembangkan bersama staf yang kompeten dan berwenang.
- (2) Pasien diskriminasi untuk kebutuhan fungsional termasuk risiko jatuh.
- (3) Pasien dengan kebutuhan fungsional lanjutan termasuk risiko jatuh, memperoleh asuhan yang sesuai ketentuan RS.

Pasal 15

- (1) Ada regulasi yang mengatur tentang mencegah pasien cedera karena jatuh.
- (2) Rumah sakit melaksanakan suatu proses pengkajian terhadap semua pasien rawat inap dan rawat jalan dengan kondisi, diagnosis, dan lokasi terindikasi berisiko tinggi jatuh sesuai dengan regulasi.
- (3) Rumah sakit melaksanakan proses pengkajian awal, pengkajian lanjutan, pengkajian ulang dari pasien rawat inap yang berdasar atas catatan teridentifikasi risiko jatuh.
- (4) Langkah-langkah diadakan untuk mengurangi risiko jatuh bagi pasien dari situasi dan lokasi yang menyebabkan pasien jatuh.

PENGKAJIAN NYERI

Pasal 16

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi pasien diskriminasi untuk rasa nyeri.
- (2) Apabila diidentifikasi ada rasa nyeri pada pengkajian awal, lakukan pengkajian lebih mendalam, sesuai dengan umur pasien, dan pengukuran intensitas dan kualitas nyeri seperti karakter, kekerapan/frekuensi, lokasi dan lamanya.
- (3) pengkajian dicatat sedemikian sehingga memfasilitasi pengkajian ulangan yang teratur dan tindak lanjut sesuai kriteria yang dikembangkan oleh rumah sakit dan kebutuhan pasien.

BAB VIII

KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 17

- (1) pengkajian awal rawat inap harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap;
- (2) pengkajian awal rawat jalan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 jam setelah dilakukan pengkajian;
- (3) pengkajian gawat darurat harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dilakukan asuhan sesuai kebutuhan pasien.

BAB IX

PENGKAJIAN TAMBAHAN

Pasal 18

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengkajian tambahan untuk populasi pasien tertentu.
- (2) pengkajian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain untuk:
 - a) Neonatus
 - b) Anak
 - c) Remaja
 - d) Obstetri/maternitas
 - e) Geriatri
 - f) Pasien dengan kebutuhan untuk P3(Perencanaan Pemulangan Pasien)
 - g) Sakit terminal/menghadapi kematian
 - h) Pasien dengan rasa sakit kronik atau nyeri (intense)
 - i) Pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatri
 - j) Pasien kecanduan obat terlarang atau alkohol
 - k) Korban kekerasan atau kesewenangan
 - l) Pasien dengan penyakit menular atau infeksius
 - m) Pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi
 - n) Pasien dengan sistem imunologi terganggu
- (3) Terhadap populasi pasien tersebut dilaksanakan pengkajian tambahan sesuai regulasi rumah sakit.

BAB X
PENGKAJIAN ULANG
Pasal 19

- (1) pengkajian ulang medis dan keperawatan dilaksanakan oleh professional pemberi asuhan yang kompeten dan berwenang sesuai rincian kewenangan klinis yang ditetapkan
- (2) Ada bukti pelaksanaan pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut.
- (3) Ada bukti pelaksanaan pengkajian ulang oleh perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien.
- (4) Ada bukti pengkajian ulang oleh profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya dilaksanakan dengan interval sesuai regulasi rumah sakit.

Pasal 20

- (1) pengkajian ulang medis dan keperawatan dilaksanakan oleh profesional pemberi asuhan yang kompeten dan berwenang sesuai rincian kewenangan klinis yang ditetapkan;
- (2) pengkajian ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut;
- (3) pengkajian ulang perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien;
- (4) pengkajian ulang oleh profesional pemberi asuhan lainnya dilaksanakan sesuai kondisi pasien.

BAB XI
PENCATATAN RENCANA ASUHAN
Pasal 21

- (1) Ada regulasi asuhan untuk setiap pasien direncanakan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat, dan PPA lainnya dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk rawat inap.
- (2) Rencana asuhan dibuat untuk setiap pasien dan dicatat oleh PPA yang memberikan asuhan di rekam medis pasien.
- (3) Rencana asuhan pasien terintegrasi dibuat dengan sasaran berdasar atas data pengkajian awal dan kebutuhan pasien.
- (4) Rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien, dimutakhirkan, atau direvisi oleh tim PPA berdasar atas pengkajian ulang.
- (5) Perkembangan pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi pada CPPT oleh DPJP sesuai dengan kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP
- (6) Pencatatan pada CPPT setiap hari terdapat 5 penulisan PPA (DPJP, Perawat, bidan, Gizi dan apoteker)
- (7) Apabila pasien ada rawat bersama, pencatatan 5 atau 6 penulisan, 2 diantaranya adalah DPJP utama dan DPJP konsulan.
- (8) Daftar urutan dokumen rekam medis rawat inap terlampir

Pasal 22

- (1) Ada regulasi tentang tindakan klinis dan diagnostik serta pencatatannya di rekam medis.
- (2) Staf yang meminta beserta apa alasan dilakukan tindakan dicatat di rekam medis pasien.
- (3) Hasil tindakan dicatat di rekam medis pasien.
- (4) Pada pasien rawat jalan bila dilakukan tindakan diagnostik invasif/berisiko harus dilakukan pengkajian serta pencatatannya dalam rekam medis.

BAB XII RINGKASAN PULANG

Pasal 23

- (1) Ringkasan pulang harus dibuat oleh dokter penanggung jawab pelayanan sebelum pasien pulang;
- (2) Ringkasan pulang diberikan kepada pasien, disimpan dalam rekam medis pasien, dan dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang akan melanjutkan asuhan pasien dan pihak ketiga seperti asuransi
- (3) Satu salinan ringkasan pulang diberikan kepada pasien dan bila diperlukan dapat diserahkan kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab memberikan kelanjutan asuhan.
- (4) Satu salinan ringkasan pulang yang lengkap ditempatkan di rekam medis pasien.
- (5) Satu salinan ringkasan pulang diberikan kepada pihak penjamin pasien sesuai dengan regulasi rumah sakit dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pihak penjamin.
- (6) Isi ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pasien;
 - b. tanggal berkunjung dan keluar rumah sakit
 - c. riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik;
 - d. diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat;
 - e. prosedur terapi dan tindakan yang telah dikerjakan;
 - f. obat yang diberikan termasuk obat setelah keluar rumah sakit;
 - g. kondisi kesehatan pasien saat akan dipulangkan
 - h. instruksi tindak lanjut.
 - i. Kebutuhan edukasi (KIE)

BAB XIII PENGATURAN PENGEMBALIAN, PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS

Pasal 24

- (1) Pengembalian dan kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap non elektronik dan elektronik pasien umum/asuransi/bpjs ketenagakerjaan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pasien pulang;
- (2) Pengembalian dan kelengkapan dokumen rekam medis

rawat inap non elektronik dan elektronik pasien bpjs selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pasien pulang;

- (3) Pengembalian dan kelengkapan dokumen rekam medis pasien rawat jalan non elektronik dan elektronik selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pasien pulang;
- (4) Pengembalian dan kelengkapan dokumen rekam medis pasien gawat darurat non elektronik dan elektronik selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pasien pulang;

Pasal 25

- (1) Unit rekam medis menetapkan pengaturan urutan assembling formulir rekam medis pasien untuk mempermudah pencarian, pengisian rekam medis pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA)
- (2) Pengkajian ulang dicatat di dokumen Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).
- (3) Pengaturan formulir - formulir rekam medis sesuai dengan daftar assembling.

Pasal 26

- (1) Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan.
- (2) Setelah batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali :
 - a) Ringkasan keluar masuk pasien
 - b) ringkasan pulang / resume medis
 - c) laporan operasi
 - d) identifikasi kelahiran bayi
 - e) persetujuan tindakan medik.
 - f) surat kematian
- (3) Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.
- (4) Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan di simpan di dalam sistem SIMRS.

BAB XIV

REKAM MEDIS GAWAT DARURAT

Pasal 27

- (1) Terdapat regulasi tentang RM pasien gawat darurat yang memuat waktu kedatangan dan keluar pasien, ringkasan kondisi pasien saat keluar dari gawat darurat, dan instruksi tindak lanjut asuhan.
- (2) Rekam medis pasien gawat darurat memuat waktu kedatangan dan keluar dari unit pelayanan gawat darurat.

-
- (3) Rekam medis pasien gawat darurat memuat ringkasan kondisi pasien saat keluar dari unit pelayanan gawat darurat.
 - (4) Rekam medis pasien gawat darurat memuat instruksi tindak lanjut asuhan.

BAB XV

PELAYANAN SEDASI DAN ANESTESI

Pasal 28

Pasien dan Keluarga

Sebelum dan setelah pemberian sedasi dan anestesi pihak keluarga atau pasien diberikan penjelasan informasi edukasi secara jelas.

Pasal 29

Pengkajian Pra sedasi/Anestesi

- (1) pengkajian pra sedasi/anestesi meliputi:
 - a. mengidentifikasi setiap permasalahan saluran pernapasan yang dapat memengaruhi jenis sedasi/anestesi;
 - b. evaluasi pasien terhadap risiko tindakan sedasi/anestesi;
 - c. merencanakan jenis sedasi/anestesi dan tingkat kedalaman sedasi/anestesi yang diperlukan pasien berdasar atas sedasi/anestesi yang diterapkan;
 - d. pemberian sedasi/anestesi secara aman; dan pengkajian
 - e. mengevaluasi serta menyimpulkan temuan monitor selama dan sesudah sedasi/anestesi.
- (2) Hasil pengkajian didokumentasikan dalam rekam medis pasien

Pasal 30

Pengkajian Pra Induksi

Dokter spesialis anestesi melakukan pengkajian pra induksi dan didokumentasikan dalam rekam medis

Pasal 31

Pelaksanaan Anestesi dan Sedasi

- (1) Catatan yang harus dilakukan untuk sedasi dan anestesi meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pengkajian pra sedasi/anestesi
 - b. Pengkajian pra induksi
 - c. monitoring status fisiologis
 - d. monitoring pemulihan sedasi/anestesi
 - e. evaluasi ulang bila terjadi konversi tindakan dari lokal/regional ke general
- (2) Pelayanan anestesi harus direncanakan dan didokumentasikan meliputi:
 - a. Teknik anestesi
 - b. Obat anestesi, dosis, dan rute

Pasal 32

Dokter spesialis anestesi melakukan edukasi dan mendokumentasikan tentang:

- a. risiko, manfaat dan alternatif dari tindakan anestesi termasuk konversi dari regional ke general
- b. pemberian analgesi pasca tindakan anestesi

Pasal 33

Selama pemberian anestesi dan operasi harus dilakukan pemantauan status fisiologis dan evaluasi secara kontinual berdasarkan status pasien pada pra anestesi, metoda anestesi yang dipakai dan tindakan operasi yang dilakukan didokumentasikan pada status anestesi.

Pasal 34

- (1) Waktu masuk ruang pemulihan dan dipindahkan dari ruang pemulihan dicatat dalam form anestesi.
- (2) Pasien dimonitor dalam masa pemulihan dicatat dalam form anestesi.

BAB XVI

PELAYANAN BEDAH

Pasal 35

Pengkajian Pra Bedah

- (1) Pengkajian pra bedah dilakukan sebelum tindakan bedah
- (2) Pengkajian pra bedah untuk melengkapi pengkajian awal bedah
- (3) Hasil pengkajian prabedah memberikan informasi tentang :
 - a. Tindakan bedah sesuai waktu dan pelaksanaan
 - b. Melakukan tindakan dengan aman
 - c. Menyimpulkan temuan selama pemantauan
- (4) Hasil pengkajian yang digunakan untuk menentukan rencana operasi dicatat oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) di rekam medis sebelum operasi dimulai, memuat tentang:
 - a. Diagnosis pra operasi
 - b. Rencana operasi

Pasal 36

Persetujuan atau Penolakan Tindakan Bedah

- (1) Sebelum pelayanan bedah diberikan harus mendapatkan persetujuan dan Informasi yang diberikan kepada pasien, atau keluarga memuat:
 - a. Risiko dari rencana tindakan operasi
 - b. Manfaat dari rencana tindakan operasi
 - c. Kemungkinan komplikasi dan dampak
 - d. Pilihan operasi atau opsi non operasi (alternatif) yang tersedia untuk menangani pasien
 - e. Sebagai tambahan, jika dibutuhkan darah atau produk darah, risiko dan alternatifnya.
- (2) Identitas pemberi penjelasan harus tercantum dalam rekam medis
- (3) Setelah pemberian informasi pasien dan atau keluarga menandatangani persetujuan atau penolakan dan tercantum namanya dengan jelas.

Pasal 37

Penandaan

- (1) Penandaan lokasi operasi dilakukan bila tindakan bedah dilakukan pada organ dua sisi serta melibatkan pasien.

-
- (2) Penandaan dilakukan pada pasien dan juga di Rekam medis pasien sebelum pasien masuk kamar operasi

Pasal 38
Pemantauan

Catatan yang harus dilakukan untuk tindakan bedah meliputi :
Monitoring status fisiologi bila tindakan bedah menggunakan anestesi lokal

Pasal 39
Laporan Operasi

- (1) Informasi terkait dengan operasi dicatat dalam laporan operasi dan digunakan untuk menyusun rencana asuhan lanjutan yang ada di CPPT
- (2) Untuk mendukung kesinambungan asuhan pasien pasca operasi, laporan operasi dicatat segera setelah operasi selesai, sebelum pasien dipindah dari ruang operasi atau dari area pemulihan pasca anestesi, yang memuat tentang:
 - a. Diagnosis pascaoperasi;
 - b. Nama dokter bedah dan asistennya;
 - c. Ada dan tidak ada komplikasi;
 - d. Spesimen operasi yang dikirim untuk diperiksa;
 - e. Specimen operasi yang dikirim untuk diperiksa;
 - f. Jumlah darah yang hilang dan jumlah yang masuk lewat transfusi;
 - g. Nomor pendaftaran alat yang dipasang (implant);
 - h. Tanggal, waktu, dan tanda tangan dokter yang bertanggung jawab.

Pasal 40
Asuhan Pasien Pasca Operasi

- (1) Asuhan pasien bedah direncanakan berdasarkan atas hasil pengkajian dan dicatat dalam form RM
- (2) Pelaksanaan rencana asuhan pasca operasi dalam bentuk SOAP selesai dalam waktu 24 jam.
- (3) Rencana asuhan pasca operasi termasuk rencana asuhan medis, keperawatan, dan PPA lainnya berdasar kebutuhan pasien.

Pasal 41
Implan

Nomor seri pemakaian implant ditempel dalam rekam medis pasien

BAB XVII
TRANSFER DAN RUJUKAN

Pasal 42
Transfer Pasien

- 1) Pemindahan pasien antar ruang pelayanan harus dilengkapi dengan form transfer pasien
- 2) Form transfer pasien sekurang-kurangnya meliputi hal-hal

sebagai berikut :

- a. Indikasi pasien dirawat
- b. Riwayat kesehatan
- c. Pemeriksaan fisik
- d. Pemeriksaan diagnostic
- e. Diagnosis
- f. Prosedur yang telah dilakukan
- g. Obat yang telah diberikan
- h. Keadaan pasien saat dipindahkan

Pasal 43

Rujukan

- 1) Dalam proses rujukan harus sudah dipastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menerima rujukan dapat memenuhi kebutuhan pasien
- 2) Dokumen rujukan sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Identitas pasien
 - b. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan
 - c. Diagnosis kerja
 - d. Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan
 - e. Tujuan rujukan
 - f. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan rujukan
- (3) Dokumen rujukan juga memuat nama fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju
- (4) Dokumen rujukan juga memuat nama staf yang menyetujui menerima pasien di fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju
- (5) Dalam dokumen rujukan juga dicantumkan kondisi pasien, termasuk saat dalam proses rujukan

BAB XVIII

REVIEW REKAM MEDIS

Pasal 44

- (1) Rekam medis pasien direview secara berkala
- (2) Review menggunakan keseluruhan dokumen rekam medis
- (3) Review rekam medis dilakukan oleh tim review yang melibatkan dokter, perawat dan PPA lainnya yang mempunyai kewenangan pengisian rekam medis atau pengelola rekam medis
- (4) Fokus review rekam medis
 - a) ketepatan tanggal dan jam pengisian
 - b) nama terang dan tanda tangan PPA
 - c) keterbacaan penulisan
 - d) pengkoreksian penulisan,
 - e) kelengkapan rekam medis,
 - f) simbol
 - g) kode diagnosa dan tindakan
 - h) singkatan diagnosa.
 - i) formulir sesuai kebutuhan professional pemberi asuhan
- (5) Proses review termasuk isi rekam medis harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

-
- (6) Review rekam medis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan mutu rekam medis.
 - (7) Review rekam medis secara kuantitatif dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan secara berkala.
 - (8) Hasil review dilaporkan secara berkala kepada Direktur rumah sakit dan PT.

BAB XIX PENUTUP

Pasal 45

Peraturan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 Januari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA MALANG
NOMOR :
TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN INSTALASI REKAM
MEDIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Informasi rumah sakit terkait asuhan pasien sangat penting untuk komunikasi antar staf klinis yang didokumentasikan dalam rekam medis. Rekam medis adalah bukti tertulis (kertas/eletronik) yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti temuan hasil pengkajian, rencana asuhan, rincian pelaksanaan asuhan dan pengobatan, catatan perkembangan pasien terintegrasi, serta ringkasan kepulangan pasien yang dibuat oleh profesional pemberi asuhan (PPA).

Penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai saat pasien diterima di rumah sakit sampai dengan pencatatan data medis, keperawatan, manajer pelayanan pasien (MPP), serta PPA lainnya selama pasien mendapat asuhan. Kegiatan dilanjutkan dengan penanganan rekam medis yang meliputi penyimpanan dan penggunaan untuk kepentingan pasien atau keperluan lainnya

1.2 TUJUAN PEDOMAN

Tujuan Umum:

Menunjang tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didukung oleh suatu sistem pengelolaan rekam medis yang cepat, tepat, bernilai, dapat dipertanggungjawabkan, serta berfokus pada pasien dan keselamatan pasien secara terintegrasi.

Tujuan Khusus:

1. Alat komunikasi antara profesional pemberi asuhan (PPA) yang memberikan asuhan pasien (*communication*);
2. Dasar dalam perhitungan biaya pelayanan kepada pasien (*financial billing*);
3. Penyedia data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan (*research & education*);
4. Dasar untuk merencanakan asuhan yang harus diberikan kepada pasien (*assessment*);
5. Bahan yang berguna untuk analisis, penelitian, dan evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien (audit klinis);
6. Sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan pelaporan;
7. Bukti tertulis/terekam atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit;
8. Pelindung kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun profesional pemberi asuhan (*legal documentation*).

1.3 RUANG LINGKUP

1. Mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, menyajikan dan mendesiminasikan informasi, menata sumber informasi bagi kepentingan riset, perencanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan
2. Membuat standar dan pedoman manajemen informasi kesehatan meliputi aspek legal dengan unsur keamanan (*safety*), kerahasiaan (*confidential*), sekuritas, privasi serta integritas data
3. Manajemen operasional unit kerja manajemen informasi kesehatan, dibagi berdasarkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menjalankan manajemen informasi kesehatannya.

1.4 BATASAN OPERASIONAL

1. Manajemen Rekam Medis
Adalah kegiatan penyelenggaraan rekam medis yang terdiri dari koding, indeksing, assembling, penyimpanan rekam medis, pendistribusian rekam medis dan pelaporan rekam medis.
2. Rekam Medis
Adalah bukti tertulis (*kertas/eletronik*) yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien seperti temuan hasil Pengkajian, rencana asuhan, rincian pelaksanaan asuhan dan pengobatan, catatan perkembangan pasien terintegrasi, serta ringkasan kepulangan pasien yang dibuat oleh profesional pemberi asuhan (PPA).
3. Admisi
Adalah tempat penerimaan / pendaftaran pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
4. ICD 10
Adalah kepanjangan dari International Classification of Disease Ten Revision. ICD 10 digunakan untuk mengkode diagnosa penyakit pasien rawat jalan maupun rawat inap.
5. ICD 9 CM
Icd 9 CM digunakan untuk mengkode tindakan yang dilakukan terhadap pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam upaya mempersiapkan tenaga rekam medis yang handal, perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan, mempertahankan sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi.

Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan perputaran orang ke dalam, di dalam dan ke luar organisasi. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Perencanaan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan oganisasi dalam mencapai sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi.

- 1. Diploma 3 (D3) Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang di tempuh selama 6 (enam) semester, dengan gelar ahli madya.
- 2. Diploma 4 (D4) Manajemen Informasi Kesehatan yang di tempuh selama 8 (delapan) semester, dengan gelar Sarjana Sains Terapan MIK.
- 3. Strata 1 (S1) Manajemen Informasi Kesehatan yang di tempuh selama 8 (delapan) semester, dengan gelar Sarjana Manajemen Informasi Kesehatan.
- 4. Strata 2 (S2) Manajemen Informasi Kesehatan yang di tempuh selama 4 (empat) semester, dengan gelar Magister Manajemen Informasi Kesehatan.

2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi	1 Shift	1
Pendaftaran/Admisi	3 Shift	14
Analisis	2 Shift	4
Pelaporan Rumah Sakit	1 Shift	1
Coding	2 Shift	1

Table 2.1 Distribusi Ketenagaan Rekam Medis

2.3 PENGATURAN JAGA

Tabel Pengaturan Jaga di Instalsai Rekam Medis :

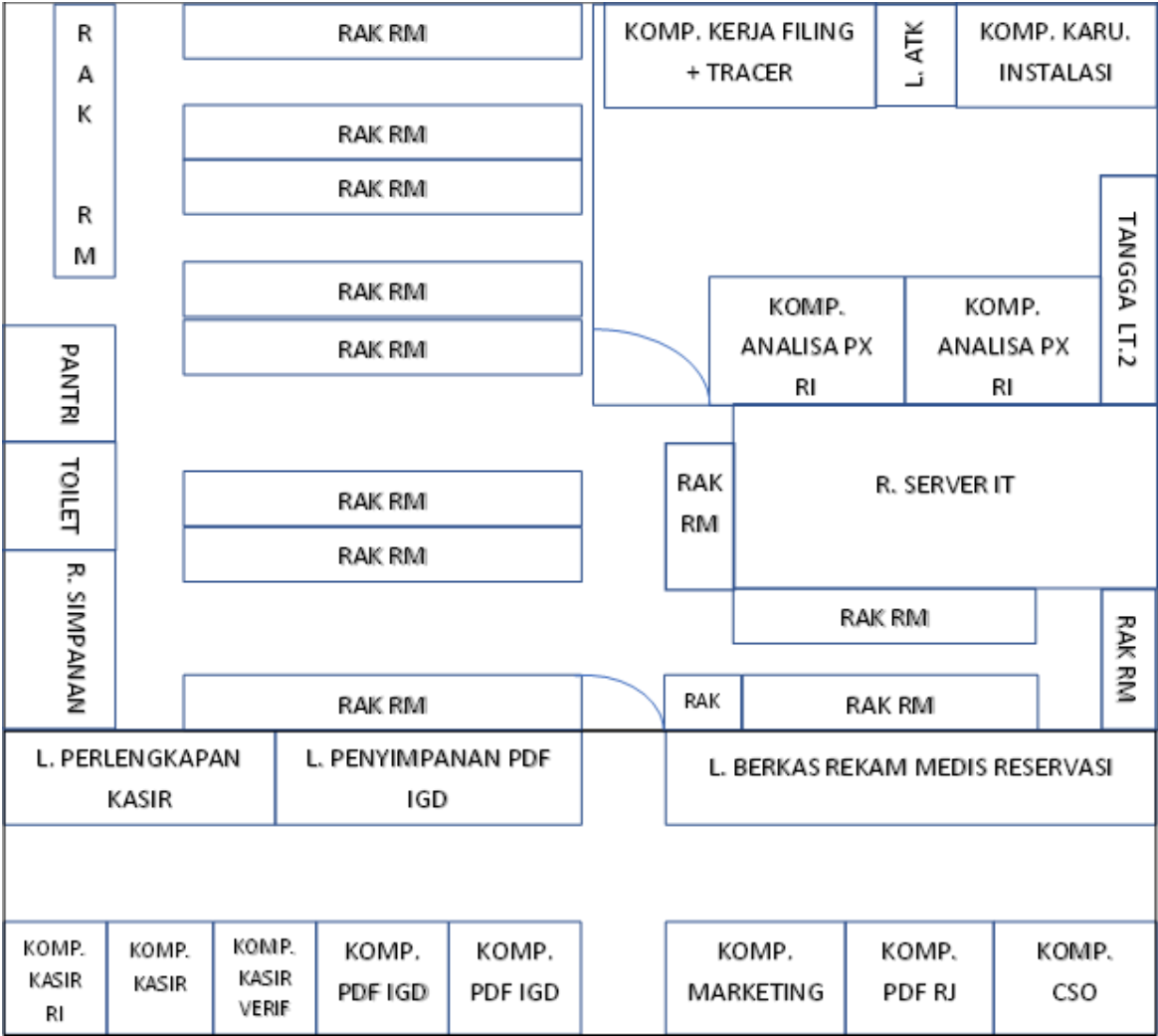
NO	SHIFT	JAM
1	Non Shift	08:00 - 16:00
2	Pagi	06:30 - 14:00
3	Siang	14:00 - 21:00
4	Malam	21:00 - 06:30

Table 2.2 Pengaturan Jam Kerja

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 DENAH RUANG INSTALASI REKAM MEDIS



Gambar 3.1 Denah Ruang Rekam Medis

3.2 STANDAR FASILITAS INSTALASI REKAM MEDIS

- 1. Letak ruang rekam medis harus memiliki tempat yang layak dan mendukung untuk pengolahan sistem ERM.
- 2. Desain tata ruang rekam medis harus dapat menjamin keamanan penyimpanan berkas rekam medis elektronik maupun non elektronik.

NO	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1	Ruangan Administrasi	1. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3~5 m2/ petugas. 2. Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. 3. Intensitas cahaya minimal 100 lux	Luasan total ruangan disesuaikan dengan kajian kebutuhan.
2	Ruangan Kepala Rekam Medik	Umum	
3	Ruangan Petugas Rekam Medik	Umum	
4	Ruangan Arsip Aktif	1. Luas ruangan tergantung jumlah arsip dan jenis pelayanan 2. Persyaratan ruangan seperti persyaratan umum	
5	Ruangan Arsip Pasif	1. Luas ruangan tergantung jumlah arsip dan jenis pelayanan 2. Persyaratan ruangan seperti persyaratan umum	
6	KM/WC petugas	1. Persyaratan KM/WC umum lihat poin di atas	

Table 3.1 Standart Fasilitas Instalasi Rekam Medis

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

Rekam medis terdiri dari dua bagian, yaitu identitas dan pemeriksaan klinik. Pemeriksaan klinik mengisahkan secara kronologis kegiatan pelayanan medis yang diterima pasien selama berada di rumah sakit. Rekam medis akan berguna nilainya bagi unsur administratif, hukum, keuangan, riset, edukasi, dan pendokumentasian rekam medis memiliki :

1. Identitas dan formulir persetujuan – persetujuan
2. Riwayat penyakit pasien secara lengkap
3. Laporan pemeriksaan fisik
4. Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan dan nama terang tenaga kesehatan yang berwenang. Instruksi per telepon dapat diterima oleh perawat dan di catat tetapi dalam waktu 24 jam instruksi tersebut harus segera ditandatangani oleh dokter yang bertanggung jawab
5. Observasi Segala laporan observasi termasuk laporan konsultasi
6. Laporan tindakan dan penemuan, termasuk yang berasal dari penunjang medik, yaitu laboratorium, radiologi, laporan operasi serta tanda tangan pasien, dokter, dan sebagainya. Untuk laporan operasi harus memuat informasi lengkap mengenai penemuan, cara operasi, benda yang dikeluarkan dan diagnosis pasca bedah.

Manfaat Rekam Medis :

1. Pengobatan pasien Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Membuat Rekam Medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal.
3. Pendidikan dan penelitian Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
4. Pembiayaan Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien.
5. Statistik Kesehatan Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit – penyakit tertentu.
6. Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan Etik Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

Tata cara penerimaan pasien yang akan berobat ke rumah sakit ataupun yang akan dirawat adalah sebagian dari sistem prosedur pelayanan RS Prima Husada. Dapat dikatakan bahwa disinilah pelayanan pertama kali yang diterima oleh seorang pasien saat tiba di rumah sakit, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa di dalam tata cara penerimaan inilah seorang pasien mendapatkan kesan baik ataupun tidak baik dari pelayanan rumah sakit. Tata cara melayani pasien dapat dinilai baik bilamana dilaksanakan oleh petugas dengan sikap yang ramah, sopan, tertib dan penuh tanggung jawab.

5.1 PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

1. PASIEN BARU

1. Pasien BPJS baru

Setiap pasien baru diterima di admisi dan akan diwawancarai oleh petugas admisi guna mendapatkan data identitas yang akan ditulis didokumen rekam medis dan di entry SIMRS (Sistem Informasi Rumah Sakit)

- 1) Pasien mengambil nomer antrian di mesin ABK dengan di arahkan oleh security ke ruang tunggu admisi
- 2) Petugas admisi memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian
- 3) Petugas admisi melakukan pengecekan persyaratan pendaftaran berupa surat rujukan dari FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama), kartu BPJS dan kartu identitas pasien.
- 4) Petugas admisi membuatkan rekam medis dengan nomor rekam medis baru di sistem SIMRS
- 5) Petugas admisi memberikan nomor antrian klinik spesialis kepada pasien dan menginformasikan untuk menunggu di ruang tunggu klinik spesialis

2. Pasien umum baru

Setiap pasien baru diterima di admisi dan akan diwawancarai oleh petugas guna mendapatkan data identitas yang akan ditulis didokumen rekam medis dan di entri di SIMRS

- 1) Petugas admisi membuatkan rekam medis dengan nomor rekam medis di simrs ,beserta kartu berobatnya
- 2) Pasien di arahkan ke kasir untuk pembayaran jasa dokter dan pengambilan nomor antrian dan kartu berobat serta pasien diarahkan ke klinik yang dituju.

3. Pasien asuransi lain baru

Setiap pasien baru diterima di admisi dan akan diwawancarai oleh petugas guna mendapatkan data identitas yang akan ditulis didokumen rekam medis dan di entri SIMRS

- 1) Petugas admisi melakukan pengecekan persyaratan pendaftaran berupa kartu asuransi dan kartu identitas pasien.
- 2) Petugas admisi membuatkan nomor rekam medis dengan nomor rekam medis baru di SIMRS.
- 3) Petugas admisi memberikan nomor antrian klinik spesialis kepada pasien dan menginformasikan untuk menunggu di ruang tunggu klinik spesialis.

2. PASIEN LAMA

1. Pasien BPJS lama

- 1) Pasien yang datang dengan JKN Mobile
 - a) Pasien lama datang untuk daftar di mesin APM
 - b) Pasien datang dengan antrian jkn mobile akan langsung dipersilahkan menuju klinik yang dimaksud setelah mendapatkan nomor antrian sesuai reservasi
- 2) Pasien yang datang sendiri atau langsung (go show)
 - a) Pasien yang datang sendiri (langsung) diwawancarai oleh petugas, guna mendapatkan informasi nomor rekam medis, dan tujuan berobat beserta kelengkapan persyaratan yang sudah di tentukan
 - b) Pasien dipersilahkan menunggu di klinik setelah mendapatkan nomor antrian,

2. Pasien umum lama

- 1) Pasien yang datang dengan perjanjian/reservasi (pasien datang atau via telepon)
 - a) Pasien lama datang ke admisi atau via telepon dan akan diwawancarai oleh petugas, guna mendapatkan informasi nomor rekam medis, dan tujuan berobat beserta kelengkapan persyaratan yang sudah di tentukan
 - b) Pasien di arahkan ke kasir untuk pembayaran jasa dokter dan pengambilan nomor antrian dan kartu berobat serta pasien diarahkan ke klinik yang dituju
 - c) Pasien datang dengan perjanjian akan langsung dipersilahkan menuju klinik yang dimaksud setelah mendapatkan nomor antrian sesuai reservasi,
- 2) Pasien yang datang sendiri atau langsung
 - a) Pasien yang datang sendiri (langsung) diwawancarai oleh petugas, guna mendapatkan informasi nomor rekam medis, dan tujuan berobat beserta kelengkapan persyaratan yang sudah di tentukan
 - b) Pasien dipersilahkan menunggu di klinik setelah mendapatkan nomor antrian,

3. Pasien asuransi lain lama

- 1) Pasien yang datang dengan perjanjian/reservasi (pasien datang atau via telepon)
 - a) Pasien lama datang ke admisi atau via telepon dan akan

diwawancarai oleh petugas, guna mendapatkan informasi nomor rekam medis, dan tujuan berobat beserta kelengkapan persyaratan yang sudah di tentukan

- b) Petugas admisi melakukan pengecekan persyaratan pendaftaran berupa kartu asuransi dan kartu identitas pasien
 - c) Pasien datang dengan perjanjian akan langsung dipersilahkan menuju klinik yang dimaksud setelah mendapatkan nomor antrian sesuai reservasi,
- 2) Pasien yang datang sendiri atau langsung
- a) Pasien yang datang sendiri (langsung) diwawancarai oleh petugas, guna mendapatkan informasi nomor rekam medis, dan tujuan berobat beserta kelengkapan persyaratan yang sudah di tentukan
 - b) Petugas admisi melakukan pengecekan persyaratan pendaftaran berupa kartu asuransi dan kartu identitas pasien
 - c) Pasien dipersilahkan menunggu di klinik setelah mendapatkan nomor antrian,

5.2 PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

Untuk pasien berasal dari klinik rawat jalan yang harus dirawat inap, pasien tersebut harus di rujuk ke IGD. DPJP membuat rujukan berisi alasan mengapa pasien harus dirawat inap. Aturan yang baik harus memenuhi hal-hal berikut :

1. Bagian penerimaan pasien bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pencatatan seluruh informasi yang berkenaan dengan diterimanya seorang pasien di RS. Prima Husada.
2. Bagian penerimaan pasien harus segera memberitahukan bagian-bagian lain terutama bagian yang berkepentingan langsung, setelah diterimanya seorang pasien untuk dirawat.
3. Harus memberitahukan bagian penerimaan pasien, apabila seorang pasien diijinkan meninggalkan rumah sakit.
4. Membuat catatan yang lengkap, terbaca dan seragam harus disimpan oleh semua bagian selama pasien dirawat.
5. Instruksi yang jelas harus diketahui oleh setiap petugas yang bekerja dalam proses penerimaan dan pemulangan pasien.

Prosedur pasien untuk dirawat inap :

1. Pasien Umum
 - a. Pasien yang akan di rawat inap dapat melihat informasi tentang ketersediaan tempat tidur di papan informasi di depan IGD
 - b. Apabila ruangan sudah tersedia, pasien segera mendaftar di admisi IGD.
 - c. Pada saat mendaftar pasien akan mendapat penjelasan tentang :
 - 1) Kapan masuk rawat inap
 - 2) Bagaimana cara pembayaran serta informasi tarif dan DPJP
 - 3) Peraturan selama pasien dirawat.
 - 4) Hak dan kewajiban pasien
 - d. Identitas pasien dirawat yang minimal berisi :
 - 1) Nama lengkap pasien
 - 2) Jenis kelamin pasien

- 3) Nomor rekam medis
- 4) Nama ruangan dan kelas
- 5) Diagnosa awal (diagnosa masuk)
- 6) Nama dokter yang mengirim
- e. Jika pasien pernah berobat ke rumah sakit atau pernah dirawat sebelumnya tim admisi tidak perlu membikinkan nomor rekam medis baru.
- f. Petugas admisi Rawat Inap segera menghubungi petugas keuangan untuk menyelesaikan pembayaran uang muka
- g. Selesai pembayaran, pasien diantar petugas keruangan

2. Pasien BPJS

- a. Pasien yang akan di rawat inap dapat melihat informasi tentang ketersediaan tempat tidur di papan informasi di depan IGD
- b. Apabila ruangan sudah tersedia, pasien segera mendaftar di admisi IGD.
- c. Pada saat mendaftar pasien akan mendapat penjelasan tentang :
 - 1) Kapan masuk rawat inap
 - 2) Bagaimana cara pembayaran serta informasi tarif dan DPJP
 - 3) Peraturan selama pasien dirawat.
 - 4) Hak dan kewajiban pasien
- d. Identitas pasien dirawat yang minimal berisi :
 - 1) Nama lengkap pasien
 - 2) Jenis kelamin pasien
 - 3) Nomor rekam medis
 - 4) Nama ruangan dan kelas
 - 5) Diagnosa awal (diagnosa masuk)
 - 6) Nama dokter yang mengirim
- e. Jika pasien pernah berobat ke rumah sakit atau pernah dirawat sebelumnya maka petugas admisi tidak perlu membikinkan nomor rekam medis baru, langsung di daftar menggunakan ERM

5.3 PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT

- 1. Proses penerimaan pasien IGD meliputi :
 - 1. Pasien datang ke IGD rumah sakit Prima Husada diterima oleh petugas perawat IGD di bawa ke ruang triage
 - 2. Dokter jaga IGD menentukan priotitas kegawatan pada pasien, apabila terdapat pasien gawat keluarga diarahkan pada petugas pendaftaran dengan membawa form daftar yang telah diberi catatan.
 - 3. Petugas pendaftaran diharuskan segera mendaftar pasien dengan prioritas gawat
- 2. Proses pendaftaran pasien IGD:
 - 1. Petugas admisi mengidentifikasi pasien selengkapny.
 - 2. Petugas pendaftaran mengecek data identitas di SIMRS untuk mengetahui apakah pasien pernah dirawat/berobat di RS. Prima Husada .
 - 3. Bagi pasien yang pernah berobat/diawat maka rekam medisnya segera dikirim ke ruang perawatan yang bersangkutan dan tetap memakai nomor yang telah dimilikinya jika dokter IGD membutuhkan dokumen rekam medis pasien tersebut, jika pasien belum memakai erm
 - 4. Bagi pasien yang belum pernah dirawat atau berobat di RS. Prima Husada maka diberikan nomor rekam medis baru.

3. Proses penerimaan pasien IGD ke rawat inap
Setelah dilakukan pengkajian dan pemberian tindakan/terapi maka pasien akan dilakukan transfer ke rawat inap. Pada proses transfer dilakukan serah terima pasien menggunakan form transfer rawat inap

5.4 MENAHAN PASIEN UNTUK OBSERVASI

Menahan pasien untuk observasi adalah menahan pasien yang membutuhkan observasi karena kondisi belum jelas atau masih menunggu hasil pemeriksaan :

1. Perawat Memberikan penjelasan pada pasien dan keluarga terkait kondisi pasien yang masih perlu observasi
2. Observasi dikerjakan maksimal 8 jam di IGD.
3. Setiap pasien observasi dimintakan persetujuan dan tandatangan pasien dan atau keluarga pasien
4. Melakukan instruksi sesuai advis dokter
5. Mencatat dilembar observasi
6. Perawat melaporkan ke dr IGD jika pasien sudah stabil
7. Dokter bisa menentukan pasien layak transfer atau tidak

5.5 TATA LAKSANA PENANGANAN PASIEN BILA TEMPAT TIDUR PENUH

1. Penuh
 1. Pasien dari IRJA/IGD yang akan rawat inap mendaftar ke bagian pendaftaran.
 2. Petugas pendaftaran menjelaskan tentang fasilitas ruang rawat inap beserta tarifnya.
 3. Keluarga memilih ruang rawat inap yang dikehendaki
 4. Petugas pendaftaran melihat daftar ruang rawat inap yang dikehendaki pasien. Bila ruang yang dikehendaki penuh, ditawarkan memilih ruang lain.
 5. Petugas pendaftaran telpon ruang rawat inap untuk daftar pasien MRS.
 6. Pasien mendapatkan nomor register rawat inap.
 7. Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan & tata tertib RS saat pasien di rawat inap
 8. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh perawat IRJ/IGD.
 9. Pasien diantar masuk kamar rawat inap oleh perawat IRJ/IGD dan perawat rawat inap.
 10. Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di kamar pasien oleh perawat rawat inap dengan disaksikan oleh perawat IRJ/IGD.
 11. Serah terima di *nurse station*.
 12. Perawat rawat inap ke kamar pasien untuk memberikan informasi & orientasi ruangan ke pasien/keluarga.
 13. Pasien selanjutnya di rawat lebih lanjut di ruang rawat inap.
2. Tunggu pasien pulang < 2jam
 1. Pasien dari IRJ/IGD yang akan rawat inap mendaftar ke bagian pendaftaran.
 2. Petugas pendaftaran menjelaskan tentang fasilitas ruang rawat inap beserta tarifnya.
 3. Keluarga memilih ruang rawat inap yang dikehendaki
 4. Petugas pendaftaran melihat daftar ruang rawat inap yang dikehendaki pasien. Bila ruang yang dikehendaki ada tetapi masih ada pasien yang akan pulang, keluarga ditawarkan apakah akan memilih ruang lain atau tidak. Bila tidak memilih ruang lain, untuk sementara pasien menunggudi IRJ/IGD.
 5. Petugas pendaftaran telpon ruang rawat inap untuk daftar pasien MRS.
 6. Pasien mendapatkan nomor register rawat inap.

7. Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan dan tata tertib RS saat pasien di

rawat inap.

8. Petugas pendaftaran telpon petugas IRJ / IGD kalau pasien menunggu sampai ruangan siap.
 9. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh perawat IRJ/IGD bila ruangan sudah siap.
 10. Pasien diantar masuk kamar rawat inap oleh perawat IRJ/IGD dan perawat rawat inap.
 11. Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di kamar pasien oleh perawat rawat inap dengan disaksikan oleh perawat IRJ/IGD.
 12. Serah terima di *nurse station*.
 13. Perawat rawat inap ke kamar pasien untuk memberikan informasi & orientasi ruangan ke pasien/keluarga.
 14. Pasien selanjutnya di rawat lebih lanjut di ruang rawat inap.
3. Tunggu pasien pulang > 2jam
1. Pasien dari IRJ/IGD yang akan rawat inap mendaftar ke bagian pendaftaran.
 2. Petugas pendaftaran menjelaskan tentang fasilitas ruang rawat inap beserta tarifnya.
 3. Keluarga memilih ruang rawat inap yang dikehendaki
 4. Petugas pendaftaran melihat daftar ruang rawat inap yang dikehendaki pasien. Bila ruang yang dikehendaki ada tetapi masih ada pasien yang rencana pulang, keluarga ditawarkan memilih ruang lain dan ruang yang dikehendaki bias dipesan setelah pasiennya pulang. Selama pasien belum mendapatkan ruang yang dipesan, pasien dikenakan tarif sesuai ruang yang ditempati saat itu.
 5. Diberikan tulisan papan tunggu ruangan
 6. Petugas pendaftaran telpon ruang rawat inap untuk daftar pasien MRS.
 7. Pasien mendapatkan nomor register rawat inap.
 8. Petugas pendaftaran menjelaskan peraturan dan tata tertib RS saat pasien di rawat inap.
 9. Petugas pendaftaran telpon petugas IRJA/IGD kalau ruang yang dipesan keluarga masih ada pasien & sementara memilih ruang lain sampai ruang yang dipesan ada.
 10. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh perawat IRJA/IGD.
 11. Pasien diantar masuk kamar rawat inap oleh perawat IRJA/IGD dan perawat rawat inap.
 12. Pasien dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di kamar pasien oleh perawat rawat inap dengan disaksikan oleh perawat IRJA/IGD.
 13. Serah terima di *nurse station*.
 14. Perawat rawat inap ke kamar pasien untuk memberikan informasi & orientasi ruangan ke pasien/keluarga.
 15. Pasien selanjutnya di rawat lebih lanjut di ruang rawat inap

5.6 SISTEM IDENTIFIKASI DAN PENOMORAN

1. Sistem Penamaan non elektronik

Sistem penamaan pada dasarnya untuk memberikan identitas kepada seorang pasien serta untuk membedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya, sehingga mempermudah/memperlancar didalam memberikan pelayanan rekam medis kepada pasien yang datang berobat ke rumah sakit. Di RS Prima Husada menggunakan sistem penamaan langsung yaitu yang ditulis dalam data base adalah nama pasien sendiri berdasarkan kartu tanda pengenal dan dapat ditambahkan sesuai dengan wawancara terakhir.

Prinsip utama yang harus ditaati oleh petugas pencatat adalah : nama pasien harus lengkap, minimal terdiri dari dua suku kata. Dengan demikian, nama pasien yang akan tercantum dalam rekam medis akan menjadi satu diantara kemungkinan ini :

1. Nama pasien sendiri, apabila namanya sudah terdiri dari dua suku kata atau lebih.
2. Nama pasien sendiri dilengkapi dengan nama suami, apabila pasien seorang perempuan bersuami.
3. Nama pasien sendiri dilengkapi dengan nama orang tua (biasanya nama ayah).

Dalam sistem penamaan pada rekam medis, diharapkan :

- a. Nama ditulis dengan huruf cetak dan mengikuti ejaan yang disempurnakan.
- b. Sebagai pelengkap, bagi pasien perempuan diakhir nama lengkap ditambah Ny. Atau Nn sesuai dengan statusnya.
- c. Pencatuman titel selalu diletakkan sesudah nama lengkap pasien.
- d. Perkataan Tuan, Saudara, Bapak, tidak dicantumkan dalam penulisan nama pasien.

2. Sistem Penomoran dan Penjajaran Rekam Medis

Rekam medis pada RS disimpan menurut nomor, yaitu menggunakan Sistem Nomor Unit (Unit Numbering System), Suatu sistem penomoran dimana sistem ini memberikan satu nomor kepada pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Setiap pasien yang berkunjung mendapatkan satu nomor pada saat pertama kali pasien datang ke rumah sakit dan digunakan selamanya pada kunjungan berikutnya.

Penjajaran dengan cara nomor langsung (Straight Numerical Filing) adalah penyimpanan rekam medis dalam rak penyimpanan secara beturut-turut sesuai dengan urutan nomornya.

1. Kelebihan:

- 1) Mudah dalam proses pengambilan maupun pengembalian dokumen rekam medis
- 2) Mudah melatih petugas-petugas yang harus melaksanakan pekerjaan penyimpanan tersebut.

2. Kekurangan :

- 1) Petugas harus memperhatikan seluruh angka nomor rekam medis sehingga mudah terjadi kekeliruan dalam penyimpanan makin besar angka yang diperhatikan, makin besar kemungkinan membuat kesalahan.
- 2) Terjadinya konsentrasi Dokumen rekam medis (DRM) pada rak penyimpanan untuk nomor besar, yaitu rekam medis dengan nomor terbaru, sehingga beberapa petugas yang bekerja bersamaan akan berdesak-desakan di satu tempat.
- 3) Pengawasan kerapian penyimpanan sangat sukar dilakukan, karena tidak mungkin memberikan tugas bagi seorang staf untuk bertanggung jawab pada rak-rak penyimpanan tertentu.

Kepada petugas pendaftaran, diperintahkan agar selalu mengecek apakah pasien sudah pernah berkunjung ke RS. Prima Husada. Seorang pasien yang sudah pernah berkunjung ke RS. Prima Husada sebelumnya tidak akan diberikan nomor baru tetapi data pasien akan dicari melalui Kartu Identitas Berobat (KIB).. Kadang-kadang terjadi kekeliruan dimana seorang pasien diberikan lagi nomor rekam medis yang baru, padahal ia telah mempunyai nomor rekam medis, kekeliruan ini dapat diperbaiki dengan membatalkan nomor baru dan tetap menyimpan rekam medisnya pada nomor lama.

Sistem nomor unit yang digunakan mempengaruhi rencana perkembangan ruang

tempat penyimpanan. Perlu sekali ruang Kosong pada rak penyimpanan sebesar

25 % karena tempat tersebut berguna untuk menyimpan rekam medis yang makin tebal.

5.7 SIMBOL DAN TANDA KHUSUS

Pada dokumen rekam medis pasien elektronik dan non elektronik tercantum simbol-simbol sebagai berikut:

1. Nomor Rekam Medis

1. non elektronik

Pada map sudah dicetak kotak untuk menuliskan nomor rekam medis yang akan diisi oleh petugas rekam medis. Penulisan nomor harus dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, ditulis tangan menggunakan spidol

2. elektronik

Pada sistem rekam medis elektronik untuk penomoran simbol dan tanda khusus akan langsung terlampir dan dipastikan jelas dan terbaca

2. Label Warna

Petugas Rekam medis akan menempelkan label warna pada dokumen rekam medis pasien di sudut kanan atas persis dibawah barisan nomor rekam medis sesuai dengan warna yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Warna Kuning untuk pasien dengan diagnosis HEPATITIS
2. Warna Hijau untuk pasien dengan TB Paru
3. Warna Merah untuk pasien dengan diagnosis HIV POSITIF

3. Tulisan Alergi

Diisi dengan alergi yang diderita oleh pasien.

4. Tulisan Rahasia

Tulisan Rahasia pada map rekam medis.

5. Tempat Menuliskan Nama dan nomor rekam medis pasien

Terdapat tempat untuk menuliskan nama dan nomor rekam medis pasien pada map rekam medis.

5.8 PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN DOKUMEN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK

1. Pengendalian Rekam Medis elektronik dan non elektronik

1. Pengendalian rekam medis elektronik ,tidak ada permintaan secara fisik dikarenakan semua sudah tersistem di dalam sistem rekam medis elektronik,jika ada permintaan ke unit rekam medis , tim rekam medis akan menyiapkan sesuai dengan kebutuhan
2. Pengendalian rekam medis non elektronik Permintaan-permintaan rutin terhadap dokumen rekam medis hanya dapat dilakukan melalui tracer. Petugas filing rekam medis harus menulis dengan benar dan jelas nama pasien, nomor rekam medis, nama peminjam serta tujuan dokumen rekam medis keluar di pencatatan keluar masuk Rekam Medis yang berbasis excel pada komputer penyimpanan rekam medis

2. Pengembalian Dokumen Rekam Medis elektronik dan elektronik

1. Pengembalian Rekam medis elektronik tidak ada pengembalian secara fisik ke ruang rekam medis
2. Pengembalian rekam medis non elektronik,Pengembalian dokumen rekam medis :
 - a. Pengembalian rekam medis rawat inap Pengembalian dokumen rekam medis rawat inap pasien bpjs ,asuransi lain dan umum Pengembalian dilakukan oleh unit rawat inap dilakukan dalam waktu 2x24 jam
Pengembalian dokumen rekam medis rawat inap pasien umum / asuransi / jasa raharja Pengembalian dilakukan oleh perawat ruangan dalam waktu 1x24 jam

-
3. Penyimpanan Rekam Medis elektronik dan non elektronik
 - a. Penyimpanan elektronik di sistem ERM tidak membutuhkan rak atau pun drn fisik, Sistem ERM membantu mengurangi ketergantungan pada berkas fisik, sehingga mengurangi ruang penyimpanan, penyimpanan ERM hanya ada di sistem SIMRS rs
 - b. Penyimpanan non elektronik (Sistem Sentralisasi)

Dengan cara Sentralisasi, menyimpan dokumen rekam medis dalam satu kesatuan baik catatan kunjungan gawat darurat, poliklinik, dan catatan pasien rawat inap setelah mendapatkan pelayanan.

 1. Kelebihan :
 - a. Mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan dokumen rekam medis
 - b. Mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan dokumen rekam medis
 - c. Mengurangi jumlah biaya yang dipergunakan untuk peralatan dan ruangan
 - d. Tata kerja dan peraturan mengenai kegiatan pencatatan medis mudah di standarkan
 - e. Memungkinkan peningkatan efisiensi kerja petugas penyimpanan
 - f. Mudah menerapkan system unit record
 2. Kekurangan:
 - a. Petugas menjadi lebih sibuk karena harus menangani dokumen rawat jalan dan rawat inap sekaligus
 4. Fasilitas Penyimpanan rekam medis
 - a. Elektronik :
 1. Rekam medis elektronik dan non elektronik disimpan dilokasi dan di dalam sistem yang aman dan media penyimpanan berbasis digital berupa :
 - a. Server
 - b. Sistem komputasi awan (clude computing) yang tersertifikasin sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan
 - c. Media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi.
 - b. Non elektronik :

Alat penyimpanan yang baik, penerangan yang baik, pemeliharaan ruangan, perhatian terhadap faktor keselamatan. Alat penyimpan rekam medis yang dipakai adalah Rak Terbuka dan jarak antara dua buah rak untuk lalu lalang, minimal atau lebih lebar dari 50 cm.
 5. Penunjuk Penyimpanan :
 - a. Elektronik :

Rekam medis elektronik yang disimpan di dalam sistem informasi rumah sakit harus di beri tata cara penunjuk guna mempercepat dan memudahkan akses saat penyimpanan dan menemukan data rekam medis.
 - b. Non elektronik :

Pada deretan dokumen rekam medis yang disimpan di rak harus diberi tanda penunjuk guna mempercepat pekerjaan menyimpan dan menemukan rekam medis. Jumlah penunjuk tergantung dari rata-rata tebalnya sebagian besar map- map rekam medis tersebut. Untuk dokumen rekam medis yang tebalnya sedang diberi penunjuk setiap 50 map. Makin tebal map-map rekam medis makin banyak penunjuk harus dibuat. Rekam medis yang aktif lebih banyak memerlukan penunjuk dari pada rekam medis-rekam medis yang kurang aktif.
 6. Perlindungan Dokumen Rekam Medis

Fungsi dokumen rekam medis bagi rumah sakit adalah sebagai sumber informasi

dalam rangka melaksanakan perencanaan, penganalisaan, pengambilan keputusan, penilaian dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya, untuk mendukung terciptanya keberhasilan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Rekam Medis diperlukan adanya ketentuan pokok kearsipan yaitu tempat atau sistem, sarana prasarana, pemeliharaan dokumen dari bahaya kerusakan.

Adapun bahaya dan kerusakan yang di maksud meliputi bahaya fisik, bahaya kimiawi, bahaya biologis serta pencurian.

1. Bahaya fisik adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh sinar matahari , hujan , banjir, kebakaran, panas dan kelembaban jika memakai hardfile
2. Bahaya kimawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan-bahan kimia.
3. Bahaya biologis adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa, ngengat dan rayap.
4. Bahaya sistem adalah resiko malware dan eror , seperti data korup dan, data hilang , jika ada pemadaman listrik akan berpengaruh ke kualitas penyimpanan data.

Kebersihan dan suhu ruang penyimpanan dalam ruang filling harus di jaga kelembabannya serta menyediakan alat pemadam api dan memberi tanda larangan merokok untuk menjaga rekam medis terhindar dari kebakaran. Kelembaban ruangan penyimpanan berdasarkan teori sekitar 50% sampai 65% dan suhu udara berkisar antara 18,8°C sampai 24,2°C (apabila suhu kurang dari normal, maka dalam waktu relatife singkat arsip-arsip akan rusak). Suhu ruang yang terdapat di dalam ruang filling juga harus memadai dengan terpasang AC atau kipas angin dalam ruangan, temperature udara kurang baik sehingga banyaknya debu dan juga akan mengakibatkan kelembaban. Menjaga kebersihan, suhu ruang, dan kerapian, serta penyimpanan server IT harus di perhatikan secara baik , mulai dari suhu ruangan ,ruangan harus ber AC dan minim dari orang lalu lalang.

6. Pelindung Rekam Medis.

- 1) Dokumen Rekam medis hardfile harus diberi sampul pelindung untuk :
 - a. Memelihara keutuhan susunan lembaran-lembaran rekam medis.
 - b. Mencegah terlepas atau tersobeknya lembaran, sebagai akibat sering dibolak- baliknya lembaran tersebut.Jenis sampul yang digunakan di RS. Prima Husada adalah dalam bentuk map, dimana maaf dilengkapi dengan penjepit (fastener) dibagian tengah untuk mengikat lembaran-lembaran pada map dan bagian tengah map harus diberi lipatan, sehingga memungkinkan bertambah tebalnya lembaran-lembaran yang disimpan di dalamnya. Map penyimpan dapat dipesan dengan pencantuman nomor-nomor yang dicetak, sehingga kelihatan rapi. Nomor harus jelas tertulis pada setiap map.
- 2) Perlindungan rekam medis elektronik (RME) dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah, seperti :
 - a. Kontrol akses
Hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi medis. Tingkat akses disesuaikan dengan peran pengguna dalam perawatan pasien.
 - b. Enkripsi data
Sistem menggunakan enkripsi data untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien.
 - c. Otentikasi dua faktor (2FA)
Langkah perlindungan tambahan untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses rekam medis elektronik.

- d. Pembatasan hak akses
 Pengguna di luar dokter dan pimpinan, seperti staf administrasi, hanya diberikan akses ke bagian-bagian tertentu dari rekam medis.
- e. Back up
 Prosedur keamanan data dan informasi perlu memperhatikan adanya ketersediaan (back up).

5.9 PEREKAM KEGIATAN PELAYANAN MEDIS

- 1. Penanggung Jawab Pengisian Rekam Medis
 RS. Prima Husada sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap wajib membuat rekam medis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, tentang Rekam Medis serta keputusan Ditjen Yan Med Nomor 78/Yan Med/RS UMDIK/YMU/1/91 maka tenaga yang berhak mengisi rekam medis di RS. Prima Husada adalah:
 - 1. Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter spesialis yang melayani pasien di RS. Prima Husada.
 - 2. Dokter tamu yang merawat pasien di RS. Prima Husada.
 - 3. Tenaga para medis perawatan dan non perawatan yang terlibat langsung dalam pelayanan antara lain ; Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Tenaga Laboratorium Klinik, Gizi, Anastesi, Penata Rontgen, Rekam Medis dan lain sebagainya.
 Dalam hal dokter ke luar negeri maka yang melakukan tindakan/konsultasi kepada pasien yang mengisi rekam medis adalah dokter yang ditunjuk oleh Direktur RS. Prima Husada.

NO	PETUGAS	HAK AKSES	MENGISI	KOREKSI
1	Dokter & Dokter Gigi yang memiliki SIP RS Prima Husada Pasien	√	a) Ringkasan keluar – masuk b) Pengkajian awal medis gawat darurat c) Pemberian informasi diagnosa dan tindakan d) Pengkajian awal medis DPJP e) Form penolakan tindakan medis (Against Medical Advice) f) Form SBAR g) Perencanaan pasien pulang h) Formulir rujukan i) Pemberian Informasi diagnosis & tindakan j) Lembar konsultasi k) Catatan perkembangan pasien terintegrasi l) Ringkasan pulang	√

			m) Surat keterangan kontrol n) Data partus o) Checklist keselamatan pasien operasi p) Pengkajian pra anastesi sedasi q) Formulir penandaan lokasi operasi r) Laporan pungsi s) Laporan operasi t) Laporan operasi section caesaria u) Observasi anastesi sedasi v) Identifikasi bayi baru lahir w) Status Bayi	
2	Fisioterapi.	√	a) Pengkajian awal medis fisioterapi b) Protokol terapi rehabilitasi medis c) Catatan perkembangan pasien terintegrasi d) Ringkasan pulang rawat jalan	√
3	Perawat.	√	a) Formulir pemberian edukasi b) Form skrining cepat IGD c) Discharge planning checklist d) Form skrining cepat IGD e) Triage f) Pengkajian awal medis gawat darurat g) Pengkajian awal keperawatan IGD h) Newss pasien dewasa i) Newss pasien anak j) Formulir transfer pasien antar unit k) Kriteria keluar-masuk ICU l) Pengkajian keperawatan pasien rawat inap m) Diagnosa dan intervensi keperawatan/kebidana	√

			n n) Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran o) Catatan perkembangan pasien terintegrasi p) Asuhan keperawatan/Kebidanan q) Lembar observasi dan implementasi harian intensive care unit (ICU) r) Observasi vital sign dan news s) Pengkajian ulang nyeri t) Pengkajian nyeri NIPPS u) Pengkajian risiko jatuh pasien dewasa v) Identifikasi bayi baru lahir w) Resume keperawatan x) Laporan operan pasien (LOP)	
4	Bidan.	√	a) Diagnosa dan intervensi keperawatan/kebidanan. b) Catatan perkembangan pasien terintegrasi c) Asuhan Keperawatan/Kebidanan. d) Observasi Inpartu e) Partograf	√
5	Petugas Rekam Medis.	√	a) Formulir pemberian informasi dan persetujuan umum (General Consent) b) Persetujuan umum untuk tindakan kedokteran c) Pemberian informasi diagnosis & tindakan. d) Pengkajian edukasi e) Formulir pemberian edukasi	-
6	Petugas Instalasi Radiologi.	√	-	-
7	Petugas Instalasi Laboratorium.	√	-	-

8	Petugas Instalasi Gizi.	√	a) Pengkajian awal gizi b) Asuhan Gizi Terintegrasi c) Daftar tilik penyerahan makan pasien rawat inap d) Catatan perkembangan pasien terintegrasi	-
9	Petugas Instalasi Kamar Operasi.	√	a) Asuhan keperawatan kamar operasi b) Surgical safety checklist c) Laporan operasi d) Laporan anastesi e) Asuhan keperawatan bedah pre operasi f) Asuhan keperawatan bedah Durante operasi g) Asuhan keperawatan bedah post operasi	√
10	Petugas Instalasi Farmasi.	√	a) Rekonsiliasi obat b) Daftar pemberian obat c) Pemantauan terapi obat d) Catatan riwayat penggunaan obat e) Catatan perkembangan pasien terintegrasi	√
12	Surveyor akreditasi sesuai penugasannya.	√	-	-
14	Manajer Pelayanan	√	a) Discharge planning checklist b) Form A – Evaluasi awal MPP	√

Table 5.1 Penanggung Jawab Pengisian DRM

2. Pencatatan (Recording)

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis. Sedangkan kegiatan pencatatannya sendiri hanya merupakan salah satu kegiatan dari pada penyelenggaraan rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di RS. Prima Husada , diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit, dan dilanjutkan dengan penanganan dokumen rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran dokumen dari tempat penyimpanan serta pengeluaran dokumen dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya.

Pencatatan disini dimaksudkan pendokumentasian segala informasi medis seorang pasien ke dalam Rekam Medis. Pada dasarnya pendokumentasian memuat data, yang akan menjadi bahan informasi. Data pasien dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu data sosial dan data medis. Data sosial didapatkan pada saat pasien mendaftarkan diri ke tempat penerimaan pasien. Data medis baru diperoleh dari pasien, apabila pasien telah memasuki unit pelayanan kesehatan. Petugas di unit pelayanan adalah dokter dan ahli-ahli profesi kesehatan lainnya (termasuk penunjangnya, seperti radiologi, laboratorium, dan lain-lain) serta unit perawatan.

Untuk mendapatkan pencatatan data medis yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dokter dan ahli-ahli di bidang kesehatan lainnya, yaitu:

1. Mencatat secara tepat waktu;
2. *Up to date*;
3. Cermat dan lengkap
4. Dapat dipercaya dan menurut kenyataan
5. Berkaitan dengan masalah dan pokok perihalnya, sehingga tidak bertele-tele;
6. Bersifat obyektif sehingga menimbulkan kesan jelas.

Kegiatan pencatatan ini melibatkan semua unit pelayanan di rumah sakit yang memberika pelayanan ataupun tindakan kepada pasien. Bentuk catatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu catatan yang bersifat kolektif dan catatan yang bersifat individual.

a. Catatan yang Bersifat Kolektif

Ini merupakan kumpulan catatan pasien-pasien yang datang ke unit pelayanan. Catatan ini dalam bentuk link yang sering disebut “google spreadsheet”. Link *Register* ini merupakan sumber utama data kegiatan rumah sakit. Pemakaian link register ini perlu dipertimbangkan secermat mungkin dan tetap memperhatikan efisiensi di bidang pengelolaan data medis serta hanya rekam medis yang mempunyai akses link tersebut. Buku register yang biasa diperlukan, diantaranya:

- 1) Link register serah terima dokumen rekam medis rawat inap
- 2) Link register serah terima dokumen rekam medis rawat jalan
- 3) Link register peminjaman dokumen rekam medis (hardcopy atau soft file)
- 4) Link register order form hard copy
- 5) Link register tanda terima permintaan klaim asuransi (pelepasan informasi)

Buku/link register tersebut dikerjakan oleh petugas-petugas di masing-masing unit pelayanannya. Setiap hari petugas di unit pelayanan menyiapkan rekapitulasi yang seiring disebut sensus harian. Sensus ini sangat berguna di dalam pengolahan data medis selanjutnya yang digunakan sebagai bahan laporan rumah sakit.

b. Catatan yang Bersifat Individual

Catatan ini mendokumentasikan segala tindakan medik yang diberikan kepada seorang pasien. Bentuk catatan ini berupa lembaran-lembaran yang dinamakan rekam medis. Pencatatan data medis ini dilakukan oleh petugas kesehatan

yang memberikan pelayanan/tindakan kepada pasien, yaitu Dokter Perawat/Bidan, Tenaga Kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan medis kepada pasien, serta petugas pencatatan medik sendiri.

Formulir rekam medis ini meliputi formulir untuk pasien rawat jalan dan formulir untuk pasien yang dirawat inap. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, tentang rekam medis/*medical record* maka :

1) Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Jalan

Isi dokumen rekam medis untuk pasien rawat jalan memuat identitas pasien, anamnese, diagnosis dan tindakan/pengobatan. Dokumen yang digunakan dapat dalam bentuk kartu yaitu Kartu Pemeriksaan Pasien dimana informasi mengenai identitas pasien, diagnosis dan tindakan yang dilakukan terhadap pasien seperti anamnese, terapi dicatat didalam kartu.

Data-data tertentu harus ditulis pada saat penderita masuk yang akan di-*entry* di komputer, dimasukkan pada saat pasien registrasi. Penyimpanan identitas pasien ini mutlak karena adalah salah satu cara untuk menunjang kelancaran pelayanan terhadap pasien, karena apabila seorang pasien lupa membawa kartu berobat maka dengan sistem komputerisasi akan membantu untuk mencari data pasien yang diperlukan dengan cepat. Karena identitas pasien ini merupakan sumber data yang selamanya harus disimpan, maka harus dibuat selengkap dan sejelasa mungkin. Data yang disimpan harus dibuat secara terperinci dan lengkap, yaitu:

- a) Nama lengkap pasien
- b) Nomor rekam medis
- c) Alamat
- d) Agama
- e) Jenis Kelamin
- f) Umur
- g) Status Perkawinan
- h) Tempat/tanggal lahir
- i) Pekerjaan
- j) Orang yang dihubungi, bila terjadi sesuatu
- k) Tanggal kunjungan rumah sakit yang pertama

Bila setelah menikah pasien pindah alamat, maka alamat lama dicoret dan dicantumkan alamat baru pada tempat yang kosong dan tanggal perubahan didokumen rekam medis tersebut untuk memudahkan pencarian alamat terakhir. Dokumen rekam medis rawat jalan berisi :

- a) Tanggal Kunjungan
- b) Rumah sakit yang melayani
- c) Diagnosis
- d) Tindakan yang diberikan
- e) Dokter yang menangani

2) Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap

Isi rekam medis untuk pasien rawat inap memuat identitas pasien, anamnese, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, diagnosis, persetujuan tindakan medis, tindakan/pengobatan, catatan perawat, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, resume akhir dan evaluasi pengobatan. Dokumen Rekam Medis pasien rawat inap terdiri dari lembaran-lembaran umum dan lembaran-lembaran khusus, serta lembaran-lembaran diagnostik/terapi. Lembaran-lembaran Umum, misalnya:

- a) Ringkasan Masuk dan Keluar

Lembaran Ringkasan Masuk dan Keluar ini sering disebut ringkasan atau lembaran muka, selalu menjadi lembaran paling depan pada suatu dokumen rekam medis. Lembaran ini berisi informasi tentang informasi tentang identitas pasien, cara penerimaan melalui cara masuk dikirim oleh serta berisi ringkasan data pada saat pasien keluar.

Lembaran ini merupakan sumber informasi untuk mengindeks rekam medis, serta menyiapkan laporan rumah sakit. Informasi tentang identitas pasien sekurang-kurangnya mencari hal-hal sebagai berikut:

- (1) Nama Pasien
- (2) Nomor Rekam Medis
- (3) Tanggal Lahir
- (4) Pendidikan
- (5) Jenis Kelamin
- (6) Agama
- (7) Alamat
- (8) Pekerjaan

Informasi lain yang perlu dicatat, diantaranya :

- (1) Status perkawinan
- (2) Cara penerimaan pasien, melalui
- (3) Cara masuk, dikirim oleh
- (4) Nama penanggung jawab pembayaran dan alamatnya
- (5) Nama keluarga terdekat dan alamatnya
- (6) Tanggal dan jam masuk ruang rawat inap
- (7) Tanggal dan jam keluar ruang rawat inap
- (8) Bagian/Spesialisasi, Ruang Rawat, Kelas
- (9) Lama dirawat
- (10) Diagnosis akhir (utama, lain-lain dan komplikasi)
- (11) Operasi/Tindakan (jika ada)
- (12) Infeksi Nosokomial dan penyebabnya (jika ada)
- (13) Immunisasi yang pernah didapat
- (14) Immunisasi yang diperoleh selama dirawat
- (15) Transfusi darah (jika ada)
- (16) Keadaan keluar
- (17) Nama dan tanda tangan dokter yang merawat

b) Anamnese dan Pemeriksaan Fisik

Tujuan pokok data anamnese dan pemeriksaan fisik adalah untuk memberikan bahan pelengkap bagi dokter untuk menetapkan diagnosis yang menjadi dasar tindakan pertolongan dan perawatan/pengobatan terhadap seorang pasien. Sebagai tambahan terhadap anamnese dan pemeriksaan fisik ini mungkin diperlukan berbagai hasil pemeriksaan laboratorium, rontgen, sebelum sampai pada satu kesimpulan mengenai diagnosis. Untuk lembaran anamnese dan pemeriksaan fisik dapat dipergunakan formulir kosong atau formulir dengan catatan penunjuk.

Pokok-pokok pengisian anamnese, meliputi:

- (1) Keluhan utama : pernyataan singkat tentang keadaan dan lamanya gejala yang timbul yang menyebabkan pasien meminta pertolongan medis, berdasarkan laporan yang diucapkan oleh pasien sendiri maupun yang mengantarkan ke dokter.
- (2) Riwayat penyakit sekarang : penjelasan detail secara kronologis tentang perkembangan penyakit pasien : sejak timbulnya gejala pertama sampai saat ini.

- (3) Riwayat penyakit yang pernah diderita : satu ringkasan tentang penyakit-penyakit, seperti infeksi akut, kecelakaan, operasi, alergi, infeksi, mental, metabolik, dsb.
- (4) Keadaan sosial . Catatan tentang status perkawinan, kebiasaan, hubungan sosial, pekerjaan dan lingkungannya.
- (5) Pengamatan ulang sistematis : untuk mengungkapkan gejala-gejala pokok, yang mungkin terlupakan oleh si pasien atau kelihatannya tidak perlu, ini untuk menentukan seberapa jauh dan teliti pemeriksaan fisik harus dilakukan.

Pemeriksaan fisik mencakup 4 langkah dasar yaitu:

- (1) Inspeksi : Melihat ke seluruh bagian tubuh.
- (2) Palpasi : Meraba berbagai bagian tubuh.
- (3) Perkusi : Mengetok daerah tertentu pada tubuh dengan jari tangan/alat , mendengar suaranya dan meneliti tingkat resistensinya.
- (4) Auskultasi : Mendengar bunyi yang terjadi karena proses fisiologis atau patologis didalam tubuh.

Anamnesa data umum pasien

Pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi kekuatan dan kekurangan diidentifikasi dan digunakan untuk membuat perencanaan pendidikan. Ada banyak variabel menentukan apakah pasien dan keluarga mau dan mampu untuk belajar.

- (1) Keyakinan dan nilai-nilai pasien dan keluarga;
Setiap pasien dan keluarga berhak menyampaikan keyakinan dan nilai-nilai yang mereka yakini kepada pihak rumah sakit dan assesmen tersebut tertulis di data pasien di rumah sakit
- (2) Kemampuan membaca, tingkat pendidikan dan bahasa yang digunakan;
Setiap orang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan tidak semua orang bisa membaca tergantung dari tingkat pendidikan seseorang pula , demikian juga dengan bahasa, terdapat berbagai macam bahasa di sekitar lingkungan kita sehingga kita juga harus mengkaji bahasa apa yang dapat diterima oleh keluarga maupun pasien ketika tenaga kesehatan memberikan edukasi, sehingga edukasi dapat tersampaikan dengan baik.
- (3) Hambatan emosional dan motivasi;
Hambatan emosional juga berpengaruh untuk penyampaian edukasi kepada pasien maupun keluarga, siap tidak siapnya seseorang menerima edukasi juga harus memperhatikan bagaimana kondisi emosional pasien tersebut. Motivasi seseorang juga berpengaruh besar, seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk menerima suatu informasi dan edukasi pesan yang disampaikan akan mudah tersampaikan dibanding orang yang tidak memiliki motivasi.
- (4) Keterbatasan fisik dan kognitif;
Keterbatasan fisik dan kognitif juga harus benar-benar diperhatikan karena penyampaian edukasi terhadap orang yang berkebutuhan fisik ini juga tidak akan sama dengan edukasi yang akan diterima oleh orang normal pada umumnya.
- (5) Kesiapan pasien untuk menerima informasi.
Kesiapan pasien untuk menerima informasi juga akan berpengaruh terhadap bagaimana penyampaian informasi yang disampaikan

seperti halnya penjelasan diatas.

c) Lembaran Grafik

Lembaran grafik memberikan gambaran kepada dokter tentang suhu, nadi, dan pernafasan seorang pasien. Pengisiannya dilakukan oleh petugas perawat, dimulai saat pasien mulai dirawat. Dalam lembaran grafik ini juga dicatat data-data tekanan darah, pemasukan dan pengeluaran cairan, defikasi. Dapat juga diisi informasi tentang kunjungan dokter, spesimen untuk laboratorium, diet dan lain-lain.

d) Perjalanan Penyakit/Perkembangan Perintah Dokter dan Pengobatan

Perintah medis tertulis adalah petunjuk dokter kepada bagian perawatan dan staf medis /paramedis mengenai semua medikasi dan pengobatan yang diberikan kepada pasien. Petugas rekam medis dalam meneliti kelengkapan lembaran perintah dokter, harus mengamati :

- (1) Semua perintah harus telah ditanda tangani oleh pemberi perintah. Perintah yang diberikan secara lisan atau lewat telepon harus ditandatangani oleh si pemberi perintah pada kunjungan berikutnya, yang menunjukkan dia benar-benar bertanggungjawab atas perintah tersebut. Untuk menghindari kekeliruan, diusahakan agar perintah lisan maupun telepon ini tidak sering terjadi.
- (2) Perintah keluar harus ditulis sebelum pasien meninggalkan rumah sakit. Jika perintah keluar belum ditulis, petugas rekam medis harus meneliti apakah ada pernyataan yang ditandatangani pasien keluar atas tanggung jawab sendiri. Pernyataan ini harus disimpan di dalam rekam medisnya. Dalam hal ini harus ada catatan dari dokternya yang menyatakan bahwa pasien telah keluar tanpa persetujuan.
- (3) Hasil-hasil pemeriksaan diagnosis yang diperintahkan/dimintakan oleh dokter harus ada di dalam rekam medis. Petugas rekam medis harus berusaha memperolehnya, untuk secepatnya disatukan dengan dokumen rekam medis yang bersangkutan.

Catatan medik harus diisi laporan-laporan tindakan/pengobatan yang diperintahkan kepada paramedis, seperti terapi inhalasi, occupational therapy, physical therapy, dan sebagainya.

e) Catatan Perkembangan

Lembaran ini mencatat secara spesifik perkembangan penyakit pasien yang ditulis dan ditandatangani oleh dokter. Catatan pertama dimulai dengan catatan pada saat pasien masuk, yang seterusnya ditambah selama pasien di dalam perawatan dan diakhiri pada saat pasien keluar atau meninggal. Catatan pada saat pasien untuk mencatat ringkasan keadaan umum pasien pada saat masuk, terutama fakta-fakta penting yang belum tercatat pada anamnesa dan pemeriksaan fisik. Fakta tersebut mungkin didapat dari keluarga pasien, dokter yang mengirim atau dari rumah sakit lain. Catatan selama pasien dalam perawatan untuk memberikan perkembangan ini harus dibuat setiap hari, setiap beberapa jam selama fase akutnya seorang pasien, dan seterusnya sesuai dengan perkembangan pasien itu sendiri. Semua tindakan yang dilakukan dicatat jam, tanggal dan jenis tindakannya. Semua catatan harus ditanda tangani oleh dokter pemeriksaan.

f) Catatan Perawat/Bidan

Catatan Perawat/Bidan digunakan oleh petugas perawatan untuk mencatat pengamatan mereka terhadap pasien dan pertolongan perawat yang telah mereka berikan kepada pasien. Catatan ini

memberikan gambaran kronologis pertolongan perawat, pengobatan yang diberikan dan reaksi pasien terhadap tindakan tersebut. Catatan

ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara sesama perawat, antara perawat dengan dokter. Ada empat kegunaan catatan perawat/bidan yaitu:

- (1) Mencatat keadaan pasien selama tidak dilihat oleh dokter. Ini adalah catatan hal-hal yang penting oleh perawat yang memberikan gambaran perspektif yang jelas tentang perkembangan seorang pasien ditentukan oleh informasi yang dicatat pada lembaran ini. Dengan bantuan catatan perawat yang ditulis secara seksama, seorang dokter dapat mengikuti perkembangan pasiennya, meskipun ia mengunjungi pasien hanya sekali dalam satu hari.
- (2) Menghemat waktu bagi dokter dan mencegah timbulnya kekeliruan. Tanpa adanya catatan tersebut, gambaran pasien dari waktu ke waktu, kepada petugas yang harus merawat pasien tersebut harus dijelaskan sendiri-sendiri keadaan seorang pasien. Hal ini tidak saja makan waktu, tetapi juga memungkinkan banyak kesalahan dalam pemberian medikasi dan pengobatan.
- (3) Sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan. Sangat perlu sekali setiap perawat harus mencatat apa-apa tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan perintah dokter, sehingga dokter dapat melihat hasilnya dan menentukan tindakan pengobatan selanjutnya. Untuk pembuktian secara hukum, catatan Perawat/Bidan berguna sebagai bukti pertolongan yang diberikan maupun bukti reaksi pasien terhadap pertolongan tersebut.

(4) Sebagai salah satu kelengkapan dokumen rekam medis.

Catatan Perawat/Bidan dimulai pada saat pasien masuk ruang perawatan dan meliputi:

- (1) Tanggal dan Jam.
- (2) Catatan-catatan tentang keadaan pasien, gejala-gejala yang tampak.
- (3) Pengobatan yang dilakukan.

Selama seorang pasien dirawat di rumah sakit, catatan Perawat/Bidan harus memuat observasi harian seorang pasien, juga rekam medisasi dan pengobatan yang diberikan.

g) Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Rontgen

Lembaran ini dipakai untuk meletakkan formulir-formulir hasil pemeriksaan laboratorium maupun rontgen yang dilakukan kepada pasien. Cara meletakkan formulir-formulir hasil pemeriksaan secara kronologis berdasarkan waktu, dimulai dari bawah, terus ke atas.

h) Ringkasan Pulang (*Resume Medis*)

Ringkasan dapat ditulis pada lembaran tersendiri yaitu lembar Ringkasan Pulang. Pengecualian bagi *resume* ini, terutama untuk pasien yang dirawat kurang 48 jam, cukup menggunakan *Resume* singkat, misalnya untuk kasus-kasus *tonsilectomy*, *adnoidectomy*, kecelakaan ringan, dan sebagainya. Tujuan dibuatnya *resume* ini adalah :

- (1) Untuk menjamin kontinuitas pelayanan medis dengan kualitas yang tinggi serta sebagai bahan yang berguna bagi dokter yang menerima pasien apabila pasien tersebut dirawat kembali.
- (2) Sebagai bahan penilaian staf medis rumah sakit.
- (3) Untuk memenuhi permintaan dari badan-badan resmi atau perorangan tentang perawatan seorang pasien, misalnya dari Perusahaan Asuransi (dengan persetujuan pimpinan)

(4) Sebagai bahan informasi bagi dokter yang bertugas dokter yang mengirim dan konsultan. Hal ini menjadi semacam insentif bagi semua dokter yang diharuskan menulis resume.

(5) Untuk diberikan tembusannya kepada asisten ahli yang memerlukan catatan tentang pasien yang pernah mereka rawat.

Resume ini harus disingkat dan hanya menjelaskan informasi penting tentang penyakit, pemeriksaan yang dilakukan dan pengobatannya. Resume ini harus ditulis segera setelah pasien keluar dan isinya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

(1) Mengapa pasien masuk rumah sakit (pertanyaan klinis singkat tentang keluhan utama, dan riwayat penyakit sekarang)

(2) Apakah hasil-hasil penting pemeriksaan laboratorium, radiologi dan fisik (hasil *negatif* mungkin sama pentingnya dengan hasil *positif*)

(3) Apakah pengobatan medis maupun operasi yang diberikan (termasuk respon pasien, komplikasi dan konsultasi)

(4) Bagaimana keadaan pasien pada saat keluar (perlu berobat jalan, mampu bergerak sendiri, mampu untuk bekerja)

(5) Apakah anjuran pengobatan/perawatan yang diberikan (nama obat dan dosisnya, tindakan pengobatan lainnya, dirujuk kemana, perjanjian untuk datang lagi)

Didalam dokumen rekam medis, lembaran resume diletakkan sesudah Ringkasan Masuk dan Keluar, dengan maksud memudahkan dokter melihatnya apabila diperlukan. Resume ini harus ditandatangani oleh dokter yang merawat bagi pasien yang meninggal tidak dibuatkan resume, tetapi dibuatkan Laporan Sebab Kematian.

3. Ketentuan Pengisian Dokumen Rekam Medis

Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap tindakan konsultasi yang dilakukan terhadap pasien, selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam harus ditulis dalam lembaran medis.

2. Semua pencatatan harus ditandatangani oleh dokter/ tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya dan ditulis nama terangnya serta diberi tanggal.

3. Pencatatan yang dibuat oleh mahasiswa kedokteran dan mahasiswa lainnya ditandatangani dan menjadi tanggung jawab dokter yang merawat atau oleh dokter pembimbingnya.

4. Catatan yang dibuat oleh Residen harus diketahui oleh dokter pembimbingnya.

5. Dokter yang merawat, dapat memperbaiki kesalahan penulisan dan melakukannya pada saat itu juga dengan cara coret penulisan yang salah serta dibubuhi paraf dan nama terang.

6. Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan

7. Jika ada kolom atau bagian yang kosong pada formulir dokumen rekam medis wajib di beri tanda – (jika memang tidak terisi secara medis dan kaidah)

Lembaran-lembaran Khusus, misalnya;

a. Laporan Operasi

b. Laporan Anestesi

c. Riwayat Kehamilan

d. Catatan/Laporan Persalinan

e. Identifikasi Bayi

5.10 PENGOLAHAN DATA MEDIS

Semua bentuk catatan , baik hasil rekapitulasi harian, maupun lembaran-lembaran formulir rekam medis merupakan bahan yang perlu diolah untuk selanjutnya dipakai

sebagai bahan laporan RS. Sebelum dilakukan pengolahan, dokumen-dokumen rekam medis tersebut diteliti kelengkapannya baik isi maupun jumlahnya.

Rekapitulasi dari sensus harian diolah untuk menyiapkan laporan yang menyangkut kegiatan rumah sakit, sedangkan formulir-formulir rekam medis diolah untuk menyiapkan laporan yang menyangkut morbiditas dan mortalitas. Kegiatan pengolahan yang dilakukan:

1. Perakitan urutan (*Assembling*) Rekam Medis

1. Perakitan urutan Rekam Medis pasien rawat jalan, meliputi:

- 1) Persetujuan Umum (*General Consent*)
- 2) Persetujuan Umum dan Tindakan Kedokteran
- 3) Pengkajian awal Medis Spesialis
- 4) Pengkajian awal Keperawatan Rawat Jalan
- 5) Catatan Perkembangan Pasien Rawat Jalan
- 6) Profil Ringkas Medis Rawat Jalan
- 7) Dokumentasi Pemberian Informasi dan Edukasi Rawat Jalan
- 8) Penempelan Hasil Laboratorium
- 9) Penempelan Hasil Radiologi
- 10) Penempelan Hasil EKG

2. Perakitan rekam medis pasien gawat darurat meliputi:

- 1) Form skrining cepat IGD
- 2) Triage
- 3) Pengkajian awal Medis Gawat Darurat
- 4) Pengkajian awal Keperawatan Gawat Darurat
- 5) Pemberian informasi diagnosis dan tindakan
- 6) Formulir pemberian edukasi
- 7) Transfer Pasien
- 8) Ringkasan medis rawat jalan

3. Perakitan rekam medis pasien rawat inap untuk meliputi :

- 1) Kertas Buram (Telaah Rekam Medis) (Lembaran)
- 2) Hasil Lab dan Radiologi Kertas Putih (Lembaran)
- 3) Surat Pengantar Rawat Inap (RM 01)
- 4) Ringkasan Keluar Masuk (RM 02)
- 5) Formulir Pemberian Informasi Dan Persetujuan Umum (General Consent) (RM 03)
- 6) Persetujuan Umum Tindakan Kedokteran (RM 05)
- 7) Pemberian Informasi Diagnosa & Tindakan (RM 06)
- 8) Pengkajian Edukasi (RM 07)
- 9) Formulir Pemberian Edukasi (RM 08)
- 10) Discharge Planning Checklist (Jika ada) (RM 09)
- 11) Form A Dan Form B (Jika Ada) (Rm 10)
- 12) Form Skrining Cepat Igd (Lembaran)
- 13) Triage (Rm 11)
- 14) Pengkajian Awal Medis Gawat Darurat (Rm 12)
- 15) Pengkajian Awal Keperawatan Igd (Rm 13)
- 16) Newws Dewasa (Jika Ada) (Rm 14)
- 17) Newws Anak (Jika Ada) (Rm 15)
- 18) Form Ama / Against Medical Advice (Jika Ada) (Rm 16)
- 19) Formulir Do Not Resuscitate / Form Dnr (Jika Ada)
- 20) Form Sbar (Rm 17)
- 21) Formulir Transfer Pasien Antar Unit (Urut Sesuai Pertama Masuk-Pulang) (Rm 18)
- 22) Kriteria Keluar - Masuk Icu (Rm 19)
- 23) Pengkajian Awal Medis Dpjp (Rm 20 A,B,C,D,E)
- 24) Pengkajian Keperawatan Pasien Rawat Inap (Rm 21)
- 25) Diagnosa Dan Intervensi Keperawatan / Kebidanan (Rm 23)

-
- 26) Pengkajian Awal Gizi (Rm 24)
 - 27) Asuhan Gizi Terintegrasi (Rm 25)
 - 28) Daftar Tilik Penyerahan Makan Pasien Rawat Inap (Rm 26)
 - 29) Rekonsiliasi Obat (Rm 27)
 - 30) Daftar Pemberian Obat (Rm 28)
 - 31) Pemantauan Terapi Obat (Rm 29)
 - 32) Catatan Riwayat Penggunaan Obat (Rm 30)
 - 33) Pemberian Informasi Diagnosa Dan Tindakan
(Sc,Normal,Curretage,Cateter,NGT,Tranfusi Dll) (Rm 31)
 - 34) Persetujuan / Penolakan Tindakan Kedokteran (Bergandengan Dengan Form
No 33) (Rm 34)
 - 35) Pemerian Informasi Rujukan (Jika Ada) (Rm 32)
 - 36) Pemberian Informasi Penundaan Pelayanan (Jika Ada) (Rm 33)
 - 37) Lembar Konsultasi (Jika Ada) (Rm 35)
 - 38) Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (Cppt) (Rm 36)
 - 39) Asuhan Keperawatan Dan Kebidanan (Rm 37)
 - 40) Lembar Observasi & Implementasi Icu/Nicu (Urutkan Sesuai Tgl Masuk (Jika
Ada) (Rm 38A,B)
 - 41) Obsevasi Vital Sign Dan News (Rm 39)
 - 42) Lembar Observasi (Jika Ada) (Rm 41)
 - 43) Monitoring Pemberian Tranfusi Darah (Jika Ada) (Rm 42)
 - 44) Lembar Observasi Dgn Lokal Anestesi (Jika Ada) (Rm 43)
 - 45) Lembar Monitoring Sedasi Ringan (Jika Ada) (Rm 44)
 - 46) Pengkajian Ulang Nyeri (Rm 45)
 - 47) Pengkajian Resiko Jatuh (Geriatrici,Dewasa,Pediatrici) (Rm 49A,B,C)
 - 48) Pengkajian Restrain (Jika Ada) (Rm 50)
 - 49) Form Observasi Pemasangan Restrain (Jika Ada) (Rm 51)
 - 50) Penempelan Hasil Laboratorium (Rm 52A)
 - 51) Penempelan Hasil Radiologi (Rm 52B)
 - 52) Penempelan Hasil Ekg (Rm 52C)
 - 53) Penempelan Hasil Lain-Lain (Rm 52D)
 - a. Form (Lab,Ekg,Cxr,Dll)
 - b. Surat Rujukan Dari Rs Lain
 - c. Checklist Orientasi Ruang Ri
 - d. Nst
 - e. Daftar Tilik (Px Operasi,Serah Terima Obat Farmasi Ri)
 - f. Checklist Edukasi Rd Sayang Ibu & Anak
 - g. Checlist Pasien Pulang
 - h. Labu Darah
 - 54) Penempelan Hasil Penting (Rm 52E)
 - a. Sep
 - b. Kk,Ktp,Dll Dari Pasien
 - c. Form Perencanaan Pasien Operasi
 - d. Surat Permintaan Tranfusi Darah (Warna Pink)
 - e. Surat Pernyataan Bersedia Rujuk (Pre Rujuk)
 - f. Surat Pernyataan Tulis Tangan / Ketik
 - g. Formulir Rujukan Pasien Dari Phm Keluar
 - h. Surat Pengambilan Jenazah
 - i. Surat Keterangan Penyebab Kematian
 - 55) Obsevasi Inpartu (Jika Ada) (Rm 53)
 - 56) Partografi (Jika Ada) (Rm 54)
 - 57) Data Partus (Jika Ada) (Rm 55)

-
- 58) Bendelan Operasi Biasa/ Section Caesaria (Jika Ada)
 - 59) Checklist Keselamatan Pasien Di Ruang Operasi (Ssc) (Rm 59)
 - 60) Formulir Penandaan Lokasi Operasi (Rm 60)
 - 61) Pengkajian Pra Anestesi/Sedasi (Rm 61)
 - 62) Laporan Pungsi (Jika Ada) (Rm 62)
 - 63) Laporan Operasi / Laporan Operasi Secti Caesaria (Rm 63 /Rm 64)
 - 64) Asuhan Keperawatan Bedah Pre Operasi (Rm 65)
 - 65) Asuhan Keperawatan Bedah Durante Operasi (Rm 66)
 - 66) Asuhan Keperawatan Bedah Post Operasi (Rm 67)
 - 67) Pengkajian Medis Pasien Menjelang Akhir Kehidupan/ Tahap Terminal (Jika Ada) (Rm 68)
 - 68) Pengkajian Awal Keperawatan Pasien Menjelang Akhir Khidupan / Tahap Terminal (Jika Ada) (Rm 69)
 - 69) Pemberian Informasi Pasien Menjelang Akhir Kehidupan /Tahap Terminal (Jika Ada) (Rm 70)
 - 70) Resume Keperawatan (Rm 71)
 - 71) Ringkasan Pulang 3 Ply (Rm 72)
 - 72) Lop (Rm 73)
 - 73) Form Penilaian Dpjp Pd Setiap Pasien / Absen Dpjp (Jika Ada) (Lembaran)
 - 74) Bendelan Form Tb Warna Kuning (Jika Ada)
4. Perakitan rekam medis pasien rawat inap kasus melahirkan meliputi:
- 1) Kertas Buram (Telaah Rekam Medis) (Lembaran)
 - 2) Hasil Lab & Radiologi Kertas Putih (Lembaran)
 - 3) Surat Pengantar Rawat Inap (Rm 01)
 - 4) Ringkasan Keluar - Masuk (Rm 02)
 - 5) Formulir Pemberian Informasi Dan Persetujuan Umum (General Consent) (Rm 03)
 - 6) Form Deteksi Dini Covid (Jika Ada) (Rm 04)
 - 7) Persetujuan Umum Untuk Tindakan Kedokteran (Rm 05)
 - 8) Pemberian Diagnosa Dan Tindakan (Rm 06)
 - 9) Pengkajian Edukasi (Rm 07)
 - 10) Formulir Pemberian Edukasi (Rm 08)
 - 11) Discharge Planning Checklist (Jika Ada) (Rm 09)
 - 12) Newws Anak (Rm 15)
 - 13) Form Sbar (Rm 17)
 - 14) Formulir Transfer Pasien Antar Unit (Urut Sesuai Pertama Masuk-Pulang) (Rm 18)
 - 15) Kriteria Keluar - Masuk Nicu (Rm 19B)
 - 16) Pengkajian Awal Medis Anak (Rm 20B)
 - 17) Pengkajian Awal Keperawatan Inap Neonatus (Rm 22)
 - 18) Diagnosa Dan Intervensi Keperawatan / Kebidanan (Rm 23)
 - 19) Pengkajian Awal Gizi (Rm 24)
 - 20) Asuhan Gizi Terintegrasi (Rm 25)
 - 21) Daftar Tilik Penyerahan Makan Pasien Rawat Inap (Rm 26)
 - 22) Rekonsiliasi Obat (Rm 27)
 - 23) Daftar Pemberian Obat (Rm 28)
 - 24) Pemantauan Terapi Obat (Rm 29)
 - 25) Catatan Riwayat Penggunaan Obat (Rm 30)
 - 26) Pemberian Informasi Diagnosa Dan Tindakan (Sc,Normal,Curretage,Cateter,Nglt,Tranfusi DII) (Rm 31)
 - 27) Persetujuan / Penolakan Tindakan Kedokteran (Bergandengan Dengan Form No 33) (Rm 34)

-
- 28) Pemerian Informasi Rujukan (Jika Ada) (Rm 32)
 - 29) Pemberian Informasi Penundaan Pelayanan (Jika Ada) (Rm 33)
 - 30) Lembar Konsultasi (Jika Ada) (Rm 35)
 - 31) Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (Cppt) (Rm 36)
 - 32) Asuhan Keperawatan Dan Kebidanan (Rm 37)
 - 33) Lembar Observasi & Implementasi Icu/Nicu (Urutkan Sesuai Tgl Masuk (Jika Ada) (Rm 38A,B)
 - 34) Observasi Ttv Dan Balance Cairan (Rm 40)
 - 35) Lembar Observasi (Jika Ada) (Rm 41)
 - 36) Monitoring Pemberian Tranfusi Darah (Jika Ada) (Rm 42)
 - 37) Pengkajian Nyeri Nipps(Rm 47)
 - 38) Pengkajian Resiko Jatuh (Geriatric,Dewasa,Pediatric) (Rm 49A,B,C)
 - 39) Penempelan Hasil Laboratorium (Rm 52A)
 - 40) Penempelan Hasil Radiologi (Rm 52B)
 - 41) Penempelan Hasil Ekg (Rm 52C)
 - 42) Penempelan Hasil Lain-Lain (Rm 52D)
 - 43) Penempelan Hasil Penting (Rm 52E)
 - 44) Identifikasi Bayi Baru Lahir (Rm 56)
 - 45) Status Bayi (Rm 57)
 - 46) Pengkajian Medis Pasien Menjelang Akhir Kehidupan/ Tahap Terminal (Jika Ada) (Rm 68)
 - 47) Pengkajian Awal Keperawatan Pasien Menjelang Akhir Khidupan / Tahap Terminal (Jika Ada) (Rm 69)
 - 48) Pemberian Informasi Pasien Menjelang Akhir Kehidupan /Tahap Terminal (Jika Ada) (Rm 70)
 - 49) Resume Keperawatan (Rm 71)
 - 50) Ringkasan Pulang 3 Ply (Rm 72)
 - 51) Lop (Rm 73)

2. Kodefikasi Diagnosa dan Tindakan (*Coding*)

Kegiatan dan tindakan serta diagnosis yang ada di dalam rekam medis harus diberi kode dan selanjutnya diindeks agar memudahkan pelayanan pada penyajian informasi untuk menunjang fungsi perencanaan, manajemen, dan riset bidang

kesehatan. Kode klasifikasi penyakit oleh WHO (*World Health Organization*) bertujuan untuk menyeragamkan nama dan golongan penyakit, cedera, gejala dan factor yang mempengaruhi kesehatan.

Sejak tahun 1993 WHO mengharuskan negara anggotanya termasuk Indonesia menggunakan klasifikasi penyakit revisi-10, *International Statical Clasification Deseasses and Health Problem 10 Revive*. ICD 10 menggunakan kode kombinasi yaitu menggunakan abjad dan angka (*alpha numeric*). Kecepatan dan ketepatan *Coding* dari suatu diagnosis sangat tergantung kepada pelaksana yang menangani rekam medis tersebut yaitu:

1. Tenaga medis dalam menetapkan diagnosis
2. Tenaga rekam medis sebagai pemberi kode
3. Tenaga kesehatan lainnya.

Penetapan diagnosis sorang pasien merupakan kewajiban hak dan tanggung jawab dokter (tenaga medis) yang terkait tidak boleh diubah oleh karenanya diagnosis yang ada dalam rekam medis harus diisi dengan lengkap dan jelas sesuai dengan arahan yang ada pada buku ICD 10. Tenaga rekam medis sebagai pemberi kode bertanggung jawab atas keakuratan kode dari suatu diagnosis yang sudah ditetapkan oleh tenaga medis. Oleh karenanya untuk hal yang kurang jelas atau yang tidak lengkap, sebelum koding ditetapkan, komunikasikan terlebih dahulu pada dokter yang membuat diagnosis tersebut.

Untuk lebih meningkatkan informasi dalam rekam medis, petugas rekam medis harus membuat koding sesuai dengan klasifikasi yang tepat. Disamping kode penyakit, berbagai tindakan lain juga harus di *Coding* sesuai klasifikasi masing-masing. *Coding* dalam rekam medis meliputi:

a. Koding Penyakit (ICD-10)

Tata cara penggunaan ICD 10 :

1) Menggunakan buku ICD - 10 Volume I berisi tentang :

- a) *Intruduction* (pendahuluan)
- b) Kelompok daftar tabulasi
- c) Kode kondisi tertentu.
- d) Petunjuk yang digunakan dalam daftar tabulasi
- e) Kategori karakteristik perintah

2) Menggunakan buku ICD - 10 Volume III berisi tentang :

- a) Penggunaan Index *Alfabetic*
- b) Susunan
- c) Kode angka
- d) Tanda perintah yang ada dalam buku ICD - 10 Volume I

3) Petunjuk dasar koding

- a) Indentifikasi tipe panyakit/luka atau kondisi lain di dalam buku ICD-10 Vol. I.
- b) Cari kata dasar (*Lead term*)
- c) Baca dan catat petunjuk kata dasar (di garis bawah).
- d) Rujuk di buku ICD - 10 Volume III
- e) Rujuk di buku ICD - 10 Volume I
- f) Tentukan kode penyakit tersebut

b. Koding Pembedahan/Tindakan (ICD 9 CM)

- 1) Identifikasi Tindakan yang akan dikode
- 2) Putuskan *Lead Term* (kunci utama)
- 3) Lihat *Lead Term* pada *Alphabetic Index*
- 4) Lokasikan setiap *modifiers*
- 5) Cek kode yang diberikan pada indeks di *Tabular List*
- 6) Cek istilah *Inclusion an Exclusion*

7) Beri kode pada tindakan

3. Analisa Dokumen Rekam Medis (*Review* Dokumen Rekam Medis)

Analisa adalah kegiatan pengkajian isi dokumen rekam medis agar rekam medis mempunyai nilai guna untuk perkembangan mutu rumah sakit. Analisa yang dilakukan di RS Prima Husada Malang adalah Analisa Kuantitatif dan Kualitatif yang dikerjakan setelah pasien pulang rawat inap (*Restropective*). Analisa/review dokumen rekam medis berfokus pada beberapa kriteria :

1. Ketepatan tanggal dan jam pengisian
2. Keterbacaan penulisan
3. Pengkoreksian penulisan
4. Penggunaan simbol
5. Penggunaan kode diagnosa dan kode tindakan
6. Penggunaan singkatan diagnosa
7. Kelengkapan rekam medis

Kegiatan analisa tidak hanya dilakukan oleh petugas rekam medis, melainkan juga dibantu oleh Tim Review yang terdiri dari dokter, perawat dan PPA lain yang memiliki otoritas pengisian rekam medis. Selain menganalisa isi dokumen rekam medis, tim review melakukan analisa/ evaluasi dan pembaharuan formulir rekam medis yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan. Review formulir rekam medis dilakukan secara berkala oleh tim review. Review atau pembaharuan formulir rekam medis dilakukan bila terjadi :

- a. Penambahan atau pengurangan kegiatan pelayanan
- b. Efisiensi pengisian formulir

4. Indeks

Indeks adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat kedalam indeks-indeks. Jenis indeks yang dibuat:

1. Indeks Penyakit (Diagnosis) dan Operasi

Suatu data base yang menyimpan kode diagnosa penyakit maupun tindakan operasi setiap pasien yang berobat di RS. Prima Husada. Indeks Penyakit dan Operasi sendiri sudah bisa dikerjakan melalui sistem komputerisasi yang bisa di-*backup* setiap waktu tertentu secara periodik sehingga data rusak atau hilang dapat dicegah. Informasi yang ada didalam data base ini adalah:

- 1) Nomor Kode Diagnosa penyakit atau tindakan operasi.
- 2) Judul, Bulan, Tahun
- 3) Nomor Penderita
- 4) Jenis Kelamin
- 5) Umur.

Data base ini dapat untuk mengindeks penyakit maupun tindakan operasi sesuai dengan informasi yang diinginkan untuk keperluan sbb:

- 1) Mempelajari kasus-kasus terdahulu dari satu penyakit untuk memperoleh pengertian tentang penanggulangan terhadap penyakit-penyakit/masalah-masalah kesehatan pada saat ini.
- 2) Untuk menguji teori-teori membandingkan data-data tentang penyakit/pengobatan dalam rangka penyuguhan tulisan-tulisan ilmiah
- 3) Menyuguhkan data untuk menyusun keperluan alat-alat baru, tempat tidur dan lain-lain.
- 4) Menilai kualitas pelayanan di RS. Prima Husada.
- 5) Menyuguhkan data pelayanan yang diperlukan dalam survey kemampuan RS. Prima Husada.
- 6) Menemukan rekam medis dimana dokternya hanya ingat diagnosa atau operasinya, sedangkan nama pasien yang bersangkutan lupa.
- 7) Menyediakan materi pendidikan untuk mahasiswa kedokteran, perawat, dll.

2. Indeks Dokter

Data base yang berisi nama dokter yang memberikan pelayanan medik kepada pasien. Indeks ini digunakan untuk keperluan penilaian kinerja dokter. Informasi yang ada didalam data base ini adalah:

- 1) Nama Dokter;
- 2) Judul, Bulan, Tahun
- 3) Nomor Penderita;
- 4) Jenis Kelamin;
- 5) Umur;

3. Indeks Kematian

Data base ini berisikan daftar pasien meninggal dan sebab terjadi kematian. Indeks Kematian digunakan untuk Statistik menilai mutu pelayanan dasar menambah dan meningkatkan peralatan/tenaga. Informasi yang tetap dalam indeks kematian:

- 1) Nama penderita
- 2) Nomor Rekam Medis
- 3) Jenis Kelamin
- 4) Umur
- 5) Kematian : kurang dari sejam post operasi
- 6) Dokter yang merawat
- 7) Hari Perawatan
- 8) Wilayah.

5.11 TATA CARA PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN REKAM MEDIS

1. Pengeluaran Rekam Medis

Ketentuan pokok yang harus ditaati ditempat penyimpanan adalah :

1. Tidak satupun dokumen rekam medis boleh keluar dari ruang Rekam Medis, tanpa tanda keluar/kartu permintaan. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang diluar rekam medis, tetapi juga bagi petugas-petugas rekam medis sendiri.
 2. Seseorang yang menerima/meminjam rekam medis, berkewajiban untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan tepat waktunya. Harus dibuat ketentuan berapa lama jangka waktu satu rekam medis diperbolehkan tidak berada di rak penyimpanan. Seharusnya setiap rekam medis kembali lagi ke raknya pada setiap akhir hari kerja, sehingga dalam keadaan darurat staf rumah sakit dapat mencari informasi yang diperlukan.
 3. Rekam medis tidak dibenarkan diambil dari rumah sakit, kecuali atas perintah pengadilan. Dokter-dokter atau pegawai rumah sakit yang berkepentingan dapat meminjam rekam medis, untuk dibawa ke ruang kerjanya selama jam kerja, tetapi semua rekam medis harus dikembalikan ke ruang rekam medis pada akhir jam kerja. Jika beberapa rekam medis akan digunakan selama beberapa hari, rekam medis tersebut disimpan dalam tempat sementara di ruang rekam medis. Kemungkinan rekam medis dipergunakan oleh beberapa orang perpindahan dari orang satu ke lain orang ini, harus dilakukan dengan mengisi "Kartu Pindah Tangan" karena dengan cara ini rekam medis tidak perlu bolak-balik dikirim ke bagian rekam medis. Kartu pindah tangan ini dikirimkan ke bagian rekam medis, untuk diletakkan sebagai penunjuk keuarnya rekam medis, Kartu pindah tangan tersebut berisi: tanggal, pindah tangan dari siapa, kepada siapa, untuk keperluan apa dan digunakan oleh dokter siapa.
- ### 2. Petunjuk Keluar (*Outguide / Tracer*) jika belum memakai RM-E
- Petunjuk keluar adalah suatu alat yang penting untuk mengawasi penggunaan

rekam medis. Dalam penggunaannya *tracer* ini diletakkan sebagai pengganti

pada tempat map-map rekam medis yang diambil (dikeluarkan) dari rak penyimpanan. Petunjuk keluar tetap berada di rak tersebut, sampai map rekam medis yang diambil (dipinjam) kembali.

Petunjuk keluar yang dipakai berbentuk kartu yang ditempel surat pinjam. Petunjuk keluar ini haruslah dibuat dari bahan (kertas) atau plastik yang keras dan kuat.

3. Ketentuan dan Prosedur Penyimpanan Lainnya

Ketentuan dasar yang membantu memperlancar pekerjaan pengelolaan rekam medis ketika memakai hardcopy:

1. Pada saat rekam medis dikembalikan ke sub bagian rekam medis, harus disortir menurut nomor, sebelum disimpan. Hal ini membantu menemukan rekam medis yang diperlukan tetapi tidak ada dalam tempat penyimpanan dan memudahkan pekerjaan penyimpanan.
2. Hanya petugas-petugas rekam medis yang dibenarkan menangani rekam medis. Dokter-dokter, staf rumah sakit, pegawai-pegawai dari bagian lain tidak diperkenankan mengambil rekam medis dari tempat penyimpanannya.
3. Rekam medis yang sampulnya rusak atau lembarannya lepas, harus segera diperbaiki, untuk mencegah semakin rusak/hilangnya lembar-lembaran yang diperlukan karena tercampur dengan dokumen lain.
4. Pengamatan terhadap penyimpanan harus dilakukan secara periodik, untuk menemukan salah simpan dan melihat kartu pinjaman yang rekam medisnya masih belum dikembalikan.
5. Rekam medis dari pegawai-pegawai sub bagian rekam medis itu sendiri atau rekam medis yang berkenaan dengan proses hukum, jangan disimpan ditempat penyimpanan biasa, harus disimpan ditempat khusus di ruangan pimpinan bagian rekam medis, sedang ditempat penyimpanan biasa diberi petunjuk.
6. Petugas penyimpanan harus memelihara kerapian dan teraturnya rak-rak penyimpanan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Rekam medis yang sedang diproses/dipakai oleh petugas sub bagian rekam medis harus diletakkan diatas meja/rak tertentu dengan maksud bahwa rekam medis tersebut setiap saat dapat dipergunakan.
8. Rekam medis yang sangat tebal harus dijadikan 2 atau 3 jilid.
9. Petugas yang mengepalai kegiatan penyimpanan harus membuat laporan rutin kegiatan yang meliputi :
 - 1) Jumlah rekam medis yang dikeluarkan setiap hari dari rak penyimpanan untuk memenuhi permintaan.
 - 2) Jumlah permintaan darurat
 - 3) Jumlah salah simpan
 - 4) Jumlah dokumen rekam medis yang tidak dapat ditemukanData tersebut berguna untuk rencana pengelolaan dan pengawasann penyimpanan rekam medis.

5.12 JANGKA WAKTU PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN KERAHASIAAN

1. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan
2. Setelah batas waktu 5 (lima) tahun dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik,

-
3. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik, disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.
 4. Berkas rekam medis yang tidak boleh di musnahkan adalah:
 1. Ringkasan keluar masuk pasien
 2. Resum medis
 3. Lembar ooperasi
 4. Lembar persetujuan
 5. Lembar kematian
 5. Dalam proses pemusnahan rumah sakit akan mengeluarkan berita acara pemusnahan.
 6. Kerahasiaan
 1. Rekam medis pasien dilindungi dari gangguan akses serta penggunaan informasi yang tidak sah.
 2. Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
 3. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:
 - 1) untuk kepentingan kesehatan pasien
 - 2) memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
 - 3) permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri
 - 4) permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 5) untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien
 4. Membuka rekam medis dalam bentuk elektronik harus memiliki atau menggunakan ID dan kata sandi khusus petugas rekam medis
 5. Permintaan informasi rekam medis diatas harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan
 7. Penyimpanan
 1. Dalam proses retensi penyimpanan ada di dalam SIMRS ,dibuatkan rumah perpasien ,sehingga setelah di scan dapat disimpan di dalam vitur rumah masing masing, dipastikan data aman.

BAB VI

LOGISTIK

Instalasi Rekam Medis RS. Prima Husada setiap bulan mempunyai permintaan rutin yang terbagi menjadi dua yaitu ATK (Alat Tulis Kantor) dan ART (Alat Rumah Tangga). ATK dan ART jadwal permintaannya setiap satu bulan dua kali pada tanggal 6 dan 21. Berikut tabel permintaan rutin Instalasi Rekam Medis RS. Prima Husada :

Table 6.1 Logistik di Rekam Medis

NO	JENIS BARANG	
I.	Instalasi Rekam Medis	
	Form rawat inap	Pulpen
	Form rawat jalan	Map file
	Form IGD	Isi steples besar
	Map DRM	Isi steples kecil
	Kertas A4	Buku folio 200 lembar
	Kertas F4	penghapus
	Pensil	Tinta print
II.	Pendaftaran	
	Box file	Paper clip no 5
	Catridedge dot martrix	Penghapus
	Continous form 2 play PRS	Pensil
	Buku folio	Tinta canon
	Amplop RS kecil	Kertas HVS
	Isi staples kecil no 10	Pulpen merah
	Isolasi kertas	Amplop RS besar
	Label no 104	ID card RSPH
	Rol register kecil	Kartu nama RSPH
	Rol register besar	Trigonal no 3

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Didalam terdapat standar yang harus dilaksanakan dalam keselamatan pasien.

1. Ketepatan Identifikasi Pasien, dalam hal ini harus terpenuhi adalah 100%. label identitas saat pasien melakukan pendaftaran/ registrasi harus memperhatikan
2. Identitas yang utama yaitu nama dan tanggal lahir, karena pencetakan label yang tidak tepat akan berpengaruh pada identifikasi selanjutnya ketika pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan terutama ketika pasien mempunyai nama yang sama.

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

UU No 23 tahun 1992 menyatakan bahwa tempat kerja wajib menyelenggarakan upaya kesehatan kerja adalah tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai paling sedikit 10 orang. Rumah Sakit adalah tempat kerja yang termasuk dalam kategori seperti disebut diatas, berarti wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja di Unit Rekam Medis bertujuan melindungi karyawan dan pelanggan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan di dalam dan di luar rumah sakit..

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini yang dimaksud pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap pekerja dalam hal ini pegawai Unit Rekam Medis dan perlindungan terhadap Rumah Sakit. Pegawai adalah bagian integral dari rumah sakit. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkatkan produktivitas pegawai dan meningkatkan produktivitas rumah sakit.

Pemerintah berkepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan semua usaha-usaha masyarakat. Pemerintah berkepentingan melindungi masyarakatnya termasuk para pegawai dari bahaya kerja. Sebab itu Pemerintah mengatur dan mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dimaksudkan untuk menjamin:

1. Agar pegawai dan setiap orang yang berada di tempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat.
2. Agar faktor-faktor produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan.

Faktor-faktor yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu :

1. Kondisi dan lingkungan kerja
2. Kesadaran dan kualitas pekerja, dan
3. Peranan dan kualitas manajemen

Dalam kaitannya dengan kondisi dan lingkungan kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi bila :

1. Peralatan tidak memenuhi standar kualitas atau bila sudah aus;
2. Alat-alat produksi tidak disusun secara teratur menurut tahapan proses produksi;
3. Ruang kerja terlalu sempit, ventilasi udara kurang memadai, ruangan terlalu panas atau terlalu dingin;
4. Tidak tersedia alat-alat pengaman;
5. Kurang memperhatikan persyaratan penanggulangan bahaya kebakaran dll.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan di bagian penyimpanan rekam medis:

1. Peraturan keselamatan harus terpampang dengan jelas di setiap bagian penyimpanan.
2. Harus dicegah jangan sampai terjadi, seorang petugas terjatuh ketika mengerjakan penyimpanan pada rak-rak terbuka yang letaknya diatas. Harus tersedia tangga anti tergelincir.
3. Ruang gerak untuk bekerja selebar meja tulis, harus memisahkan rak-rak penyimpanan.

-
4. Penerangan lampu yang cukup baik, menghindarkan kelelahan penglihatan petugas.
 5. Harus tersedia rak-rak penyimpanan yang dapat diangkat dengan mudah atau rak- rak beroda.
 6. Perlu diperhatikan pengaturan suhu ruangan, kelembaban, pencegahan debu, dan pencegahan bahaya kebakaran.

BAB IX

PENINGKATAN MUTU

Prinsip dasar upaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit. Defenisi Indikator adalah ukuran atau cara mengukur sehingga menunjukkan suatu indikasi. Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk bisa melihat perubahan. Indikator yang baik adalah yang sensitif tapi juga spesifik. Standar dalam menentukan indikator meliputi :

- 1. Tingkat performance atau keadaan yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang dalam situasi tersebut, atau oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat performance atau kondisi tersebut.
- 2. Suatu norma atau persetujuan mengenai keadaan atau prestasi yang sangat baik.
- 3. Sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu.

Dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan maka harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

- 1. Aspek yang dipilih untuk ditingkatkan
 - a. Keprofesian
 - b. Efisiensi
 - c. Keamanan pasien
 - d. Kepuasan pasien
 - e. Sarana dan lingkungan fisik
- 2. Indikator yang dipilih
 - a. Indikator lebih diutamakan untuk menilai output daripada input dan proses
 - b. Bersifat umum, yaitu lebih baik indikator untuk situasi dan kelompok daripada untuk perorangan.
 - c. Dapat digunakan untuk membandingkan antar daerah dan antar Rumah Sakit
 - d. Dapat mendorong intervensi sejak tahap awal pada aspek yang dipilih untuk dimonitor
 - e. Didasarkan pada data yang ada.
- 3. Kriteria yang digunakan

Kriteria yang digunakan harus dapat diukur dan dihitung untuk dapat menilai indikator, sehingga dapat sebagai batas yang memisahkan antara mutu baik dan mutu tidak baik.
- 4. Standar yang digunakan

Standar yang digunakan ditetapkan berdasarkan :

 - a. Acuan dari berbagai sumber
 - b. Benchmarking dengan Rumah Sakit yang setara
 - c. Berdasarkan trend yang menuju kebaikan

9.1 INDIKATOR MUTU

Table 9.1 Macam-macam Indikator Mutu di RS Prima Husada Malang

No	Indikator	Standar
1	Kesalahan pendaftaran pasien	0%
2	Angka Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	0%
3	Angka Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	0%

9.2 URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Table 9.2 Indikator angka kejadian nomor rekam medis ganda

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kesalahan Pendaftaran Pasien
b) Dasar Pemikiran	Proses pendaftaran pasien merupakan tahap awal dalam pelayanan kesehatan yang sangat menentukan ketepatan identitas pasien. Kesalahan pada tahap ini dapat berdampak pada kesalahan pelayanan, keselamatan pasien, serta administrasi dan klaim. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan untuk meminimalkan kesalahan pendaftaran.
c) Dimensi Mutu	Keselamatan, Akurasi, Efektivitas
d) Tujuan	Menurunkan angka kejadian kesalahan dalam proses pendaftaran pasien
e) Definisi Operasional	Kesalahan pendaftaran pasien adalah ketidaksesuaian data identitas pasien (nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, alamat, jenis kelamin, atau data penting lainnya) yang terjadi pada saat proses pendaftaran
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	0
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pendaftaran pasien dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua kejadian kesalahan input data pasien saat pendaftaran. Eksklusi: Perubahan data yang dilakukan atas permintaan pasien dan telah melalui prosedur yang benar
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Audit data pendaftaran, telaah rekam medis, dan laporan insiden
n) Sumber Data	Sistem pendaftaran/SIMRS, rekam medis, laporan insiden
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit pendaftaran, checklist verifikasi identitas pasien
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien yang melakukan pendaftaran (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kesalahan, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: human error, sistem, kurangnya verifikasi identitas)
t) Penanggung Jawab	Petugas Pendaftaran, Kepala Unit Pendaftaran, Instalasi Rekam Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Table 9.2 Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Pasien BPJS TK Tidak Memasukkan dalam Sistem E-PLKK
b) Dasar Pemikiran	Sistem E-PLKK digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan pasien BPJS Ketenagakerjaan. Ketidakinputan data pasien ke dalam sistem dapat berdampak pada klaim, pelaporan, serta aspek administrasi dan

	legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan untuk memastikan seluruh pasien BPJS TK tercatat dalam sistem.
c) Dimensi Mutu	Efektivitas, Akurasi, Kepatuhan, Administrasi
d) Tujuan	Menjamin seluruh pasien BPJS TK terinput dalam sistem E-PLKK secara tepat dan lengkap
e) Definisi Operasional	Kejadian pasien BPJS TK tidak dimasukkan dalam sistem E-PLKK adalah kondisi dimana pasien peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan pelayanan tidak tercatat/input dalam sistem E-PLKK pada periode pelayanan
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah pasien BPJS TK yang tidak terinput dalam sistem E-PLKK dalam periode tertentu
i) Denominator (Penyebut)	
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Semua pasien peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan pelayanan. Eksklusi: Pasien dengan kendala sistem nasional (down system), atau kondisi force majeure yang terdokumentasi
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Audit data pelayanan dan pencocokan dengan data pada sistem E-PLKK
n) Sumber Data	Data pendaftaran pasien, SIMRS, sistem E-PLKK
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit E-PLKK, checklist verifikasi input data
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien BPJS TK (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase kejadian, grafik tren, serta analisis penyebab (misalnya: kelalaian petugas, kendala sistem, kurangnya verifikasi)
t) Penanggung Jawab	Petugas Pendaftaran, Petugas Klaim/Billing, Kepala Unit Rekam Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Table 9.3 Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI

Komponen	Uraian
a) Judul Indikator	Kejadian Ketidaksesuaian Tanggal Pengunjungan Pasien Rawat Inap dengan SPRI
b) Dasar Pemikiran	Ketepatan pencatatan tanggal pengunjungan pasien rawat inap dengan Surat Perintah Rawat Inap (SPRI) sangat penting untuk menjamin akurasi data pelayanan, kelancaran administrasi, serta ketepatan klaim pembiayaan. Ketidaksesuaian data dapat berdampak pada kesalahan klaim dan mutu pelayanan.
c) Dimensi Mutu	Akurasi, Efektivitas, Kepatuhan, Administrasi
d) Tujuan	Menjamin kesesuaian tanggal pengunjungan pasien rawat inap dengan data pada SPRI
e) Definisi Operasional	Ketidaksesuaian tanggal pengunjungan adalah kondisi dimana tanggal masuk/rawat pasien di sistem atau rekam medis tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam SPRI
f) Jenis Indikator	Indikator Proses
g) Satuan Pengukuran	Angka
h) Numerator (Pembilang)	Jumlah kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien rawat inap dengan SPRI dalam periode tertentu

i) Denominator (Penyebut)	-
j) Target Pencapaian	0
k) Kriteria Inklusi dan Eksklusi	Inklusi: Seluruh pasien rawat inap yang menggunakan SPRI. Eksklusi: Perubahan tanggal yang telah dikoreksi sesuai prosedur dan terdokumentasi, serta kendala sistem (force majeure)
l) Formula	-
m) Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen dan pencocokan data antara rekam medis/SIMRS dengan SPRI
n) Sumber Data	Rekam medis, SIMRS, dokumen SPRI
o) Instrumen Pengambilan Data	Form audit kesesuaian data, checklist verifikasi SPRI
p) Populasi / Sampel	Seluruh pasien rawat inap dengan SPRI (total sampling)
q) Periode Pengumpulan Data	Bulanan
r) Periode Analisis dan Pelaporan Data	Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan
s) Penyajian Data	Tabel persentase ketidaksesuaian, grafik tren, serta analisis penyebab (human error, kesalahan input, kurangnya verifikasi)
t) Penanggung Jawab	Petugas Pendaftaran, Instalasi Rekam Medis, Petugas Rawat Inap, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Table 9.4 Indikator angka kejadian nomor rekam medis ganda

Judul Indikator	Angka kejadian nomor rekam medis ganda
Definisi Operasional	Duplikasi nomor rekam medis adalah suatu keadaan pasien yang memiliki dua atau lebih nomor rekam medis ataupun satu nomor rekam medis dimiliki oleh dua orang pasien atau lebih. Duplikasi penomoran rekam medis pada umumnya disebabkan oleh proses identifikasi data pasien pada proses registrasi yang kurang tepat.
Tujuan	Untuk menyajikan informasi data yang valid dan baik , sehingga tidak akan terjadi pelayanan yang terhambat serta mengurangi waktu tunggu pasien menjadi lama,meminimalisir terjadinya salah pemberian terapi
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Adanya nomor rekam medis ganda yang membuat tidak berkesinambungan informasi data kesehatan sehingga menyulitkan suatu pelayanan kesehata.
Numerator	-
Denominator	-
Formula pengukuran	Pengiriman data dilakukan setiap menemukan nomer rekam medis ganda di input secara real time
Metode pengumpulan data	Dokumen
Cakupan data	Rekam Medis
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	1 bulan

Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren
Sumber data	• Pendaftaran • rekam medis
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

Table 9.4 Indikator angka kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang peningkatan mutu pelayanan rekam medis elektronik

Judul Indikator	Angka kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang peningkatan mutu pelayanan rekam medis elektronik
Definisi Operasional	Kejadian kendala pada simrs yang menghambat
Definisi Operasional	Kejadian keterlambatan pelaporan KLB (kejadian luar biasa) dari rumah sakit kepada pusat (dinkes)
Tujuan	Untuk mengembangkan pelayanan dan meningkatkan mutu atau kualitas kesehatan

Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Adanya KLB (kejadian luar biasa) yang harus dilaporkan ke pusat (dinkes) sebagai kejadian yang harus segera di tangani agar tidak menyebabkan wabah di sekitar masyarakat
Numerator	-
Denominator	-
Formula pengukuran	-
Metode pengumpulan data	-
Cakupan data	Rekam medis
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	1 bulan
Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren
Sumber data	Rekam medis
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

Table 9.5 Indikator Angka Ketidaklengkapan Pengkajian Awal Medis (DPJP) Pasien RI 1x24 jam

Judul Indikator	Angka ketidaklengkapan Assesmen Awal Medis (DPJP) Pasien Rawat Inap 1x24 jam
Definisi Operasional	Angka ketidaklengkapan Assesmen awal medis yang di lakukan oleh dokter penannggung jawab pasien (DPJP) di rawat inap lebih dari 24jam
Tujuan	Untuk menjaga kualitas/mutu isi rekam medis
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Adanya ketidaklengkapan Assesmen Awal Medis (DPJP) Pasien Rawat Inap sehingga menyebabkan sulitnya Analisa / pengolahan informasi kesehatan
Numerator	Jumlah DRM yang Assesmen awal medisnya tidak lengkap perbulan
Denominator	Jumlah seluruh DRM pasien pulang perbulan
Formula pengukuran	$\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$
Metode pengumpulan data	Dokumen
Cakupan data	Rekam medis
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	1 bulan
Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren
Sumber data	Rekam medis
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

Table 9.6 Indikator Kejadian Ketidaklengkapan Laporan Operasi

Judul Indikator	Kejadian ketidaklengkapan laporan operasi
Definisi Operasional	Kejadian ketidaklengkapan pengisian rekam medis pada form laporan operasi oleh dokter penanggungjawab pasien
Tujuan	Untuk menjaga kualitas/mutu isi rekam medis
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Adanya Kejadian ketidaklengkapan laporan operasi yang mempengaruhi system pengolahan data seperti claim hingga tingkat keselamatan pasien
Numerator	-
Denominator	-
Formula pengukuran	Dihitung setiap terjadi / di temukannya laporan operasi yang tidak lengkap
Metode pengumpulan data	Dokumen
Cakupan data	Rekam medis
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	1 bulan
Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren

Sumber data	Rekam medis
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

Table 9.7 Indikator Kejadian Ketidaklengkapan Form Inform Consent

Judul Indikator	Kejadian ketidaklengkapan form persetujuan / penolakan tindakan
Definisi Operasional	Ketidaklengkapan pengisian form persetujuan / penolakan tindakan
Tujuan	Untuk menjaga mutu isi rekam medis valid di ranah medis dan hokum
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Adanya Kejadian ketidaklengkapan form persetujuan / penolakan tindakan yang membuat sebuah informasi data tidak bisa di pertanggungjawabkan secara medis maupun hokum
Numerator	-
Denominator	-
Formula pengukuran	Dihitung setiap terjadi / di temukannya kejadian ketidaklengkapan form persetujuan / penolakan tindakan yang tidak lengkap
Metode pengumpulan data	Dokumen
Cakupan data	Rekam medis
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	1 bulan
Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren
Sumber data	Rekam medis
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

Table 9.8 Indikator Tingkat Hunian Rawat Inap

Judul Indikator	Tingkat hunian rawat inap
Definisi Operasional	Tempat tidur terpakai dalam frekuensi satu hari
Tujuan	Untuk mengetahui jumlah tempat tidur terpakai dalam satu hari
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Pengembangan pelayanan serta evaluasi rumah sakit terhadap rawat inap jumlah tempat tidur dan kunjungan pasien rawat inap
Numerator	-
Denominator	-
Formula pengukuran	Jumlah pasien masuk perhari – jumlah pasien keluar perhari
Metode pengumpulan data	Dokumen
Cakupan data	Instalasi Rawat inap Rekam medis

Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
-------------------------------	---------

Frekuensi Analisa data	1 bulan
Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren
Sumber data	Instalasi rawat inap
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

Table 9.9 Indikator Survey Pemahaman Staf Terhadap Evakuasi Pasien

Judul Indikator	Survey pemahaman staf terhadap evakuasi pasien
Definisi Operasional	Pemahaman staf yang ada di rekam medis terhadap evakuasi pasien
Tujuan	Untuk meningkatkan pelayan serta kesiagaan
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Kesiagaan serta kewaspadaan yang harus di jaga terhadap pelayan pasien di sebuah rumah sakit
Numerator	(a) Staf yang sudah menjalani pelatihan evakuasi pasien
Denominator	(b) Jumlah seluruh staf yang ada
Formula pengukuran	$\frac{a}{b} \times 100\%$
Metode pengumpulan data	Dokumen
Cakupan data	Rekam medis
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	1 bulan
Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren
Sumber data	Rekam medis
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

Table 159.10 Indikator Kejadian Ketidaklengkapan Ringkasan Pulang

Judul Indikator	Kejadian ketidaklengkapan Ringkasan Pulang
Definisi Operasional	Ketidaklengkapan pengisian rekam medis pada form Ringkasa Pulang
Tujuan	Untuk menjaga mutu isi rekam medis sehingga dapat dipertanggungjawabkan
Dimensi Mutu	Kesinambungan
Dasar pemikiran/alasan pemilihan indikator	Adanya Kejadian ketidaklengkapan pengisian rekam medis pada form ringkasan pulang menyebabkan tidak validnya suatu penyajian informasi data dari rekam medis terhadap pihak yang membutuhkan
Numerator	(a) Jumlah DRM yang ringkasan pulang nya tidak lengkap perbulan
Denominator	(b) Jumlah seluruh DRM pasien pulang
Formula pengukuran	$\frac{a}{b} \times 100\%$
Metode pengumpulan data	Dokumen
Cakupan data	Rekam medis

Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Frekuensi Analisa data	1 bulan
Metode Analisa data	Diagram bar dan Tren
Sumber data	Rekam medis
PJ pengumpul data	Rekam medis
Publikasi data	Laporan bulanan rekam medis

BAB X

PENUTUP

Puji syukur yang tak terhingga kami pajatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya Buku Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis RS Prima Husada. Buku ini adalah sebagai acuan di dalam setiap kegiatan proses pelayanan Rekam Medis RS Prima Husada demi tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil dapat dicapai suatu pelayanan rekam medis yang relevean.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan suport dan doanya, terutama kepada semua petugas Rekam Medis RS Prima Husada, kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyusunan buku Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis RS Prima Husada.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tercapainya pedoman suatu pelayanan yang optimal.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 30 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M. Kes